



Diario Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán

Anexo I. d)

Edificio Administrativo Siglo XXI
Dirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso
Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán.
C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92

Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. José Alfonso Lozano Poveda.

-SUMARIO-

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

PROGRAMA ESPECIAL

**PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES**



Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

MENSAJE DEL GOBERNADOR

Yucatán merece un gobierno con una visión clara, informada y estratégica que reduzca el margen de improvisación en las decisiones de política pública; en pocas palabras, Yucatán merece un gobierno cuyas acciones respondan de manera efectiva a las más grandes y profundas necesidades de la gente.

En los últimos meses, en todo el mundo nos hemos visto afectados por la pandemia global del coronavirus, la cual ha causado severas afectaciones a la salud pública, la economía y la dinámica social como la conocemos. Por este motivo, desde el inicio de la pandemia, hemos trabajado con dos prioridades; la primera y la más importante, cuidar la salud de todos y a la par, proteger el empleo y el ingreso de las familias.

Ante este panorama atípico y complejo, el Gobierno del Estado de Yucatán ha procurado en todo momento estar a la altura de la situación. Hoy más que nunca, requerimos ser un gobierno eficiente, transparente y austero que nos permita, entre otras cosas, hacer más con menos. Pero también, necesitamos hacer uso de la planeación y sus instrumentos, que, desde el inicio de esta Administración, nos han ayudado a definir el camino a seguir.

Con esta visión, y conscientes de los cambios que ha traído consigo la pandemia, es que continuamos con los procesos de planeación, como es el caso de nuestros Programas de Mediano Plazo Especiales e Institucionales que nos sirven como una herramienta para diseñar e implementar estrategias en temas prioritarios para nuestro estado.

En la presente Administración, por ejemplo, asumimos el compromiso de promover y proteger los derechos y la salud de las niñas y las mujeres. Ante las cifras de embarazo infantil y adolescente en Yucatán, desde el inicio emprendimos acciones concretas para contribuir a la reducción del embarazo en niñas y adolescentes, como la instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La emisión de este Programa de Mediano Plazo, resultado del trabajo en conjunto de la ciudadanía, gobierno, sociedad civil organizada e iniciativa privada, nos servirá como una herramienta multidimensional para encaminar nuestros esfuerzos en la estrategia para la disminución del embarazo en adolescentes.

Invito a todas y todos los yucatecos a hacer suyo este ejercicio de planeación. Que la sociedad en su conjunto; mujeres, hombres, emprendedores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil se involucren en el seguimiento de estos instrumentos y de manera conjunta logremos trabajar y avanzar como estado. Son tiempos difíciles, pero unidos somos más fuertes, el compromiso del Gobierno del Estado con la sociedad yucateca es firme, trabajar incansablemente por Yucatán.

Sigamos trabajando unidos, como uno solo.

C. Mauricio Vila Dosal

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

MENSAJE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES

Estos últimos años han sido de gran oportunidad para el desarrollo de Yucatán. Todo principio viene acompañado de múltiples desafíos, pero también de compromisos y expectativas. A nivel local nos encontramos en un momento clave para ser agentes de cambios sociales, teniendo como prioridad a la población más vulnerable.

Sin duda alguna, la contingencia sanitaria por el COVID-19 ha agudizado los problemas sociales que tienen un mayor impacto en la población que vive en situaciones de desigualdad; por tales motivos, los retos actuales ante los hechos históricos que vivimos nos dejan la encomienda de continuar trabajando para llevar a cabo acciones que fortalezcan los derechos de las y los adolescentes en este nuevo contexto.

Desde el inicio de esta Administración, en la Secretaría de las Mujeres tenemos la encomienda de llevar a cabo acciones que prevengan y erradiquen los embarazos en adolescentes, fenómeno que en los últimos años ha ido en crecimiento a nivel nacional, local y que recientemente se ha hecho más visible. Además, este fenómeno tiene una relación con las diversas formas de violencias que viven las niñas y adolescentes del estado.

Para lograr esta encomienda, fue importante partir de un análisis profundo, no sólo de cuestiones estadísticas en torno a los embarazos en adolescentes, sino también teniendo como punto de partida un diagnóstico que pudiera dar cuenta de la complejidad de este fenómeno, así como el amplio espectro que abarca. Lo anterior, para poder trazar una ruta de llegada, un programa de mediano plazo. Así, se decidió que para fortalecer la estrategia a seguir en esta materia se emitiría el presente **Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes**.

Como se puede observar a lo largo del documento, este es un proyecto hecho desde la colectividad. El diagnóstico, las mesas de trabajo y los diseños estratégicos se elaboraron en conjunto con mujeres, hombres, adultas y adolescentes, iniciativa privada, sociedad civil organizada, especialistas, así como instituciones de la administración pública; en el caso de estos últimos, se identificaron proyectos y acciones que se han estado llevando a cabo.

Aunque estamos conscientes de los avances, tenemos presente que aún hay un largo camino por recorrer. Es por ello que el **Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes** será nuestra guía a seguir. Se plantean los desafíos, pero también las áreas de oportunidad desde una perspectiva inter seccional, de derechos humanos y cultura de paz.

En el equipo interdisciplinario de la Secretaría de las Mujeres estamos comprometidas ante la urgencia por disminuir y erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, así como las formas de violencia que los circundan. Nuestro objetivo es que a partir de este Programa se genere una mayor participación a nivel ciudadanía, organizaciones civiles, iniciativa privada y función pública, de una manera empática e informada.

C. María Herrera Páramo

Secretaria de las Mujeres

MENSAJE DE SEPLAN

Uno de los principales retos que enfrenta cualquier organismo de planeación en el país es vincular de manera efectiva la planeación con la implementación de la política. Es por ello que el presente documento se basa en una sólida metodología que se nutre de herramientas que permiten que la planeación dirija el actuar gubernamental a lo largo del tiempo, a través de acciones determinadas con base en evidencia.

Ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19, todos los actores de la sociedad se enfrentan a grandes retos para afrontar las afectaciones derivadas de esta situación y sin lugar a dudas los organismos de planeación no son la excepción.

Es por esto que se requiere orientar la planeación gubernamental hacia la reconstrucción del estado preservando el equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social. La fase de recuperación posterior a esta crisis sanitaria nos brinda la oportunidad de reflexionar acerca de las medidas para extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales en el estado, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los yucatecos.

En 2019 se publicó el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 de Yucatán identificando problemas públicos socialmente relevantes, con un análisis causal de las problemáticas y la determinación de oportunidades para su atención, asimismo este ejercicio permitió sumar las propuestas y visión de los ciudadanos. Posteriormente y por primera vez en la historia de Yucatán, se emitieron los Programas de Mediano Plazo Sectoriales, Especiales y Regionales, de acuerdo a los tiempos establecidos en la normatividad. Hoy, conscientes de la necesidad de no dejar margen para la improvisación sobre los temas prioritarios para el Estado, se emite una serie de Programas de Mediano Plazo Especiales; cuyos objetivos, estrategias y líneas de acción se plantean con una visión realista para su cumplimiento, teniendo muy presente el panorama actual y las proyecciones para los años siguientes.

Los Programas de Mediano Plazo son guías que permiten tener una referencia clara durante toda la administración, logrando que los esfuerzos no dependan de una persona sino de una política pública que tenga como base instituciones.

Como resultado de la dedicación, compromiso y el trabajo riguroso de todos los involucrados, se generó este documento, que estamos seguros será un instrumento esencial para la implementación de políticas públicas sostenibles, vanguardistas e integrales, que ante la situación que enfrentamos ayudará a que Yucatán siga avanzando.

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación



TABLA DE CONTENIDO

Metodología	6
Marco legal.....	8
Alineación con la planeación nacional y estatal.....	10
¿Qué somos hoy? ¿Qué queremos ser mañana?	15
Misión sectorial.....	15
Visión sectorial.....	15
¿Dónde estamos?.....	15
Diagnóstico general.....	15
i. Estructura de la población infantil y adolescente.....	17
ii. Nacimientos, entre niñas y adolescentes, en Yucatán y sus municipios.....	17
iii. Educación.....	19
iv. Salud sexual y reproductiva.....	21
v. Violencia sexual.....	22
vi. Oportunidades laborales.....	23
Principales hallazgos.....	25
¿Dónde se quiere estar? ¿Qué se hará para lograrlo?	27
¿Cómo se medirá y evaluará?	32
Programas y proyectos estratégicos.....	43
Seguimiento y evaluación.....	44
Relación de los programas especiales con la elaboración de la programación y el presupuesto.....	46
Anexos.....	48
Referencias.....	78



METODOLOGÍA

Con el fin de garantizar el pleno desarrollo integral de las personas, es indispensable tener a los derechos humanos como los ejes rectores para la planeación estratégica en el estado; por ello, el **Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024** (PED) se estructura con base en los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA) y estratégicamente plantea el **Eje Transversal: Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación**, buscando impulsar el desarrollo igualitario en el bienestar de la población, haciendo valer los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, para abatir las brechas existentes. Sobre este aspecto, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024, en el Eje Transversal: Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación, destaca que “el embarazo en niñas y adolescentes es una manifestación de violencia y que además de ser un problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, también este fenómeno multifactorial es un obstáculo para su progreso personal, social y profesional y limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades”.

En este contexto, para la construcción del **Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes** se adoptaron la perspectiva de derechos humanos, juventudes y género, a través de un proceso de planeación estratégica, participativa e inter seccional, con una visión que privilegia la atención a niñas y adolescentes del estado, con especial énfasis en aquellas que pertenecen a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De igual manera, la construcción del Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes se realizó teniendo como marco de referencia los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en concordancia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024.

La recolección de la información necesaria para la construcción del presente Programa se llevó a cabo mediante asesorías presenciales especializadas, mesas de trabajo, talleres, cuestionarios y revisión documental, contemplando el uso de herramientas y técnicas participativas, cualitativas y cuantitativas. Para ello, se contó con la participación de dependencias integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), Organizaciones de la Sociedad Civil especialistas en la temática, y población adolescente.

De esta manera, a partir de la revisión de documentos como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y de diversas fuentes oficiales, se analizó información estratégica sobre los múltiples factores que influyen en la prevalencia del embarazo en la infancia y adolescencia, de manera contextual y que afectan a la entidad, incluyéndose información.

Con ello, se determinó la importancia de atender el embarazo en la infancia y adolescencia de manera eficaz, coordinada y oportuna en el estado.

Aunado a ello, con base en la información recolectada a partir del uso de herramientas y técnicas participativas, se consideraron para la formulación de este Programa las diversas propuestas de mujeres y hombres, adolescentes y adultos, pertenecientes a la sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanía y gobierno especialistas en temas de género, violencias y embarazo en adolescentes.

Todo esto contribuyó a determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas mediante el análisis FODA, precisando de esta forma las temáticas de atención prioritaria, los objetivos, estrategias y líneas de acción que contribuirán a alcanzar las metas propuestas, en alineación con las metas de la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 y el marco legal correspondiente.

Finalmente, es importante mencionar que, para la instrumentación del presente Programa, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) puso a disposición de la Secretaría de las Mujeres diversas herramientas documentales como la Guía Técnica para la elaboración del Programa de Mediano Plazo (PMP), formatos y bases de datos, así como una propuesta de estructura de los contenidos del documento.



MARCO LEGAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26 define la planeación como democrática y deliberativa, con mecanismos de participación para recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y programas de desarrollo. Para ello, dispone el funcionamiento de un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de México. Derivado de ello, la Ley de Planeación establece en su artículo 2º que la planeación debe ser un medio para un desempeño eficaz del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, dirigiendo los esfuerzos a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos establecidos para la nación.

A nivel estatal, la Constitución Política del Estado de Yucatán establece las facultades y obligaciones del Gobernador (a) en el artículo 55, entre las que se mencionan en la Fracción XXII el establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Estatal de Planeación Integral y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, institucionales y operativos. A continuación, en la Fracción XXIII se contempla elaborar y remitir el Plan Estatal de Desarrollo, sus actualizaciones, los programas mencionados en la fracción XXII y los criterios usados para su construcción al Congreso del Estado.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán (LPDEY) en su artículo 4º Fracción VIII define los programas de mediano plazo (PMP) como los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales que derivan del Plan Estatal de Desarrollo. Deben ser evaluables, congruentes entre sí y expresar en indicadores los resultados del desarrollo deseado, así como objetos de seguimiento y evaluación (Art. 26) y deberán observar congruencia con el Plan Nacional y sus programas de mediano plazo (Art 29). El presente documento es un programa especial, es decir, está elaborado para planificar un ámbito específico o estratégico, de carácter institucional, de interés para la implementación de una política o estrategia derivada de los instrumentos de planeación (Art. 36) con especificaciones sobre su contenido en el artículo 37. Es pertinente mencionar que, de acuerdo con el Artículo 45 de dicha ley, una vez publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en el ámbito de sus competencias.

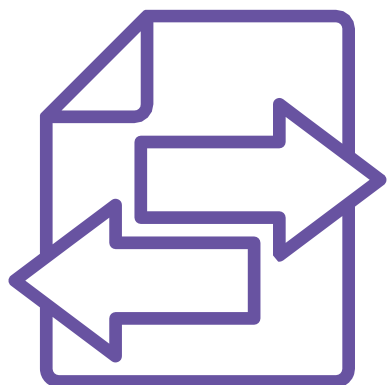
La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan), es el órgano responsable de coordinar el Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal. Asimismo, es el responsable de la elaboración del Plan de Estatal de Desarrollo y la formulación de los programas de mediano plazo mediante la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, así como de verificar que se ajusten a los objetivos e instrumentos de planeación federales, acorde con lo establecido en la LPDEY en el artículo 23 ter, Fracciones I y II.

El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 es el instrumento rector de la planeación en Yucatán, al que se sujetan de manera obligatoria todas las dependencias y entidades de la Administración Pública en el ámbito de sus competencias, dado su carácter reglamentario establecido en los artículos 26, 43 y 45 de la LPDEY.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) es una herramienta dinámica de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Busca facilitar la realización de acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales que transformen las condiciones que motivan el embarazo en niñas y adolescentes, sus determinantes económicos, sociales y culturales, así como sus causas subyacentes.

La ENAPEA es de vital relevancia para la planeación en materia de prevención y atención del embarazo en adolescentes, siendo un ejercicio fundamental para el alcance de la igualdad de oportunidades y trato de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) establece en el artículo 14 que en los Estados se deberán crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre hombres y mujeres mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres (Fracción II); así como, elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance debidamente armonizadas con los programas nacionales (Fracción III).

En el caso de Yucatán, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), según el artículo 47 quinquies del Código de la Administración Pública de Yucatán, es la responsable de coordinar la elaboración y aplicación de las políticas públicas, programas y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, tiene la facultad de proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal políticas, programas y acciones en la materia o coadyuvar con su aplicación. También, la LGIMH le otorga la atribución de promover, entre los tres poderes del Estado y la Sociedad Organizada, acciones dirigidas a mejorar la condición social de las mujeres y la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.



ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL Y ESTATAL

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se encuentran alineados con la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), y el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (PED).

Cuadro 1. Alineación a instrumentos de planeación nacionales, estatales y Agenda 2030.

Eje-Objetivo PND	Eje-Objetivo PED	ODS Agenda 2030	Tema Estratégico-Objetivo
Eje general 1: Política y gobierno	Eje transversal 5: Igualdad de género, oportunidades y no discriminación	Objetivo 4: Educación de calidad	Tema Estratégico I: Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes
Objetivo: Libertad e Igualdad. Impulsar la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y compromiso en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros.	Objetivo 5.1.2. Reducir las brechas de género en educación.	Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.	Objetivo 1.1. Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.

Eje-Objetivo PND	Eje-Objetivo PED	ODS Agenda 2030	Tema Estratégico- Objetivo
---------------------	---------------------	-----------------	----------------------------------

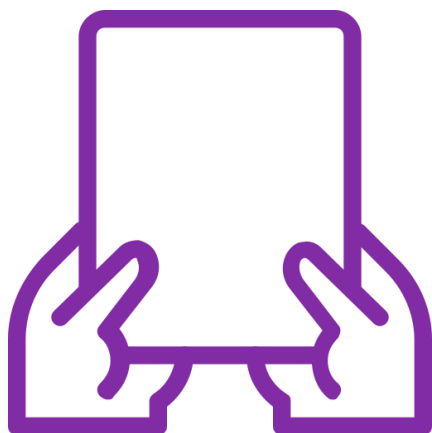
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Eje general 1: Política y gobierno	Eje transversal 5: Igualdad de género, oportunidades y no discriminación	Objetivo 5: Igualdad de género	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes
Objetivo: Cambio de paradigma en seguridad. Se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas. Se pondrá especial	Objetivo 5.1.4. Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado.	Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.	Objetivo 1.2. Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes.

Eje-Objetivo PND	Eje-Objetivo PED	ODS Agenda 2030	Tema Estratégico-Objetivo
énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y el asalto en transporte público.			
Eje general 2: Política social	Eje transversal 5: Igualdad de género, de oportunidades y no discriminación	Objetivo 3: Salud y bienestar	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes
Objetivo: Salud para toda la población. A través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva.	Objetivo 5.1.1. Reducir las brechas de género en salud.	Meta 3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Objetivo 5: Igualdad de género Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el	Objetivo 1.3. Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las niñas y los adolescentes.

Eje-Objetivo PND	Eje-Objetivo PED	ODS Agenda 2030	Tema Estratégico-Objetivo
		Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.	
Eje general 1: Política y gobierno	Eje transversal 5: Igualdad de género, oportunidades y no discriminación	Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida
Objetivo: Cambio de paradigma en seguridad. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.	Objetivo 5.1.3. Incrementar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.	Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.	Objetivo 2.1. Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables.
Eje general 2: Política social	Objetivo 5.2.1. Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad.	Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.	
Objetivo: Cultura para la paz, para el bienestar y para todos. Se promoverá la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta diversidad cultural que posee el país.		Objetivo 10 Reducción de las desigualdades	
Objetivo: El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional. De esta manera se tendrá un país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y juventud plenas.		Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	

Eje-Objetivo PND	Eje-Objetivo PED	ODS Agenda 2030	Tema Estratégico-Objetivo
Eje general 1: Política y gobierno	Eje transversal 5: Igualdad de género, oportunidades y no discriminación	Objetivo 5: Igualdad de género	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida
Objetivo: Cambio de paradigma en seguridad. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.	Objetivo 5.1.1. Reducir las brechas de género en salud.	Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.	Objetivo 2.2. Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos.



¿QUÉ SOMOS HOY? ¿QUÉ QUEREMOS SER MAÑANA?

Misión sectorial:

Ser un gobierno que transversaliza la perspectiva de género, juventudes y derechos humanos en la administración pública, disminuyendo la discriminación y fomentando la igualdad de oportunidades en el desarrollo de niñas y adolescentes; combatiendo las condiciones que obstaculicen su acceso a una vida digna.

Visión sectorial

Hacer de Yucatán un estado en el que las y los adolescentes cuenten con las mismas oportunidades para su desarrollo, promoviendo la igualdad de género a través de acciones para la prevención del embarazo en la adolescencia y la erradicación del embarazo en la infancia, que fortalecen el empoderamiento, prevención y atención de las violencias contra las adolescentes y niñas.

¿DÓNDE ESTAMOS? DIAGNÓSTICO GENERAL

El embarazo infantil y adolescente es un problema público multifactorial cuyas consecuencias repercuten negativamente en el desarrollo de las niñas y adolescentes y tienden a agravar las desigualdades sociales y de género (GIPEA, 2020, p.15). En México y en Yucatán, en 2018, por cada mil niñas de 10 a 14 años se registraron 1.6 nacimientos y por cada mil adolescentes de 15 a 19 años se registraron 66 y 59 nacimientos, respectivamente. Sobre el caso estatal cabe enfatizar que las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) pueden ser especialmente alarmantes si se consideran casos municipales concretos: los seis municipios con las más altas TEF en niñas presentan tasas entre nueve y siete veces mayores que el promedio estatal y los seis municipios con las más altas TEF en adolescentes prácticamente duplican el promedio de la entidad.

La probabilidad de ser madre en la infancia o en la adolescencia aumenta entre la población que se encuentra en situación de pobreza y, al mismo tiempo, los embarazos infantiles y adolescentes contribuyen a la reproducción intergeneracional de la pobreza. Las bajas expectativas y la falta de oportunidades escolares y laborales, aunadas a la idea de que el rol fundamental de las mujeres es el de ser madres y esposas encargadas del hogar y la familia, hace de las adolescentes en situación de pobreza, un grupo especialmente vulnerable, a tener un embarazo adolescente que dificulte su movilidad social (Rodríguez Vignoli, 2012). Además de los estereotipos sociales sobre el rol de las mujeres en la vida pública y privada, el estigma en torno a la sexualidad premarital obstaculiza el acceso de las y los adolescentes a la información necesaria para acceder a una sexualidad responsable, así como a los métodos anticonceptivos necesarios para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (Stern, 1997).

De manera adicional, la violencia sexual dirigida a niñas y adolescentes, en Yucatán, incrementa el riesgo de que éstas sufran un embarazo infantil o adolescente. En 2012, Yucatán ocupó el tercer lugar respecto a las entidades con mayores tasas de relaciones asimétricas en la primera relación sexual de niñas, niños y adolescentes; y en 2016, un 3% de las mujeres de 15 años y más reportó que su primera relación sexual fue sin consentimiento. Asimismo, a pesar de la legislación en contra del matrimonio infantil, las niñas y adolescentes aún pueden vivir uniones que ponen en riesgo sus derechos sexuales y reproductivos. En 2018, el 19.42% de las mujeres entre 20 y 24 años en Yucatán afirmó que se casó o unió antes de cumplir la mayoría de edad.

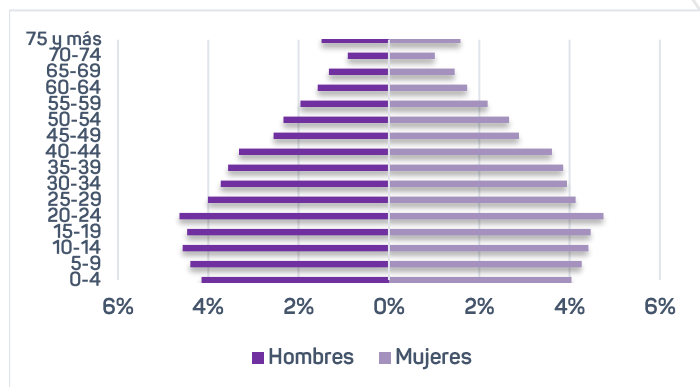
Entre las consecuencias para el desarrollo humano y social, cabe destacar que el embarazo, parto y puerperio, en la infancia y adolescencia, particularmente antes de los 18 años implica mayores riesgos de salud para las madres y los bebés; sobre todo, en casos de desnutrición y falta de atención médica. Además, dificulta la permanencia escolar y se asocia a una incorporación precaria en el mercado de trabajo. Por lo anterior, a nivel mundial existe un consenso político amplio en favor de la erradicación del embarazo infantil y la reducción del embarazo adolescente (Rodríguez Vignoli, 2012, p.69).

I. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

De acuerdo con las proyecciones demográficas, en 2020¹, en México hay aproximadamente 127,191,826 habitantes; de los cuales el 51.04% son mujeres y el 48.96% son hombres (CONAPO, 2018). En tanto que, en Yucatán², hay aproximadamente 2,246,505 habitantes; de los cuales, 1,140,016 son mujeres (51%) y 1,106,489 son hombres (49%).

Tanto a nivel nacional como a nivel estatal, considerando todas las edades, existen dos puntos porcentuales más de mujeres que de hombres; específicamente, en Yucatán, en el 2015, habían 96.1 hombres por cada 100 mujeres (INEGI, 2016). Si consideramos a la población de Yucatán por grupos de edad, entre los cero y los catorce años tiende, levemente, a haber más hombres que mujeres; sin embargo, de los 15 años en adelante la tendencia se invierte y hay más mujeres que hombres (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentajes de población por grupos quinquenales de edad según sexo en Yucatán, 2015.



Fuente: INEGI. 2015a. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados, Yucatán, Población.

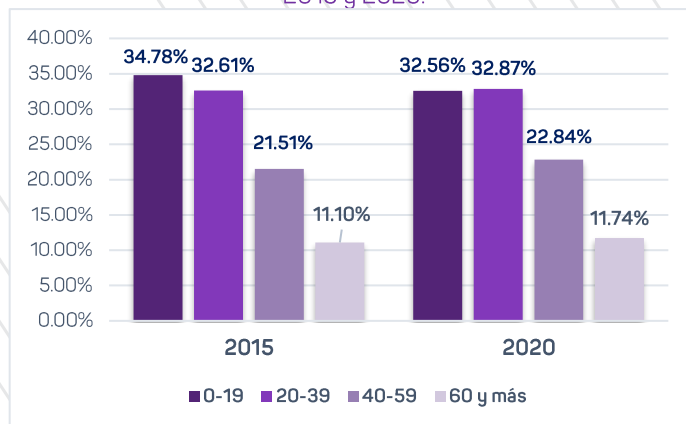
Si dividimos a la población de Yucatán en cuatro grupos de edad (Ver Gráfica 2), en 2015, el grupo de niñas/os y adolescentes³ fue el más grande seguido del grupo de personas adultas de 20 a 39 años; en tanto que en 2020 estos dos grupos representan prácticamente la misma proporción poblacional, 32.56% y 32.87%. A mitad de 2020⁴, se espera que las niñas y niños representen el 24% de los habitantes de Yucatán, y las y los adolescentes el 8.51%.

¹ En el 2015, en México habían 119,530,753 habitantes; de los cuales el 51.4% eran mujeres y el 48.6% eran hombres, 61,474,620 mujeres y 58,056,133 hombres (INEGI 2015).

² En el 2015, en Yucatán habían 2,097,175 habitantes; de los cuales el 51% eran mujeres y el 49% eran hombres, 1,069,627 mujeres y 1,027,548 hombres (INEGI 2015a).

El grupo de personas adultas de 40 a 59 años es el tercero con una proporción de 22.84% del total de la población y el grupo de personas adultas de 60 años y más es el menor con una proporción de 11.74%.

Gráfica 2. Porcentajes de población por grupos de edad en Yucatán, 2015 y 2020.



Fuente: INEGI. 2015a. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados, Yucatán, Población; CONAPO. 2018. Proyecciones de población a mitad de año en los municipios.

II. NACIMIENTOS, ENTRE NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN YUCATÁN Y SUS MUNICIPIOS

El embarazo infantil se debe fundamentalmente a la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, situación que se agudiza en contextos rurales e indígenas, así como entre los niveles socioeconómicos más bajos (Pantelides 2004; Szasz y Lerner, 2012).

En la primera década del siglo XX, ocurrieron a nivel mundial aproximadamente dos millones de partos de niñas menores de 15 años, siendo América Latina y el Caribe la única región del mundo en donde aumentaron en el periodo que va de 1990 a 2011 (UNFPA, 2013). **En México, en 2016, casi 12 mil nacimientos fueron de madres de 10 a 14 años** (CONAPO, 2017).

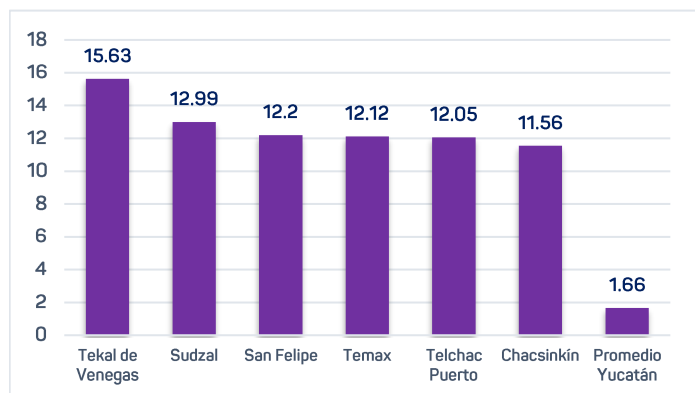
La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) en niñas de 10 a 14 años, entre 2015 y 2018, a nivel nacional ha presentado una tendencia descendente, en tanto que a

³ Considerando los rangos de edad empleados por la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), podemos considerar niñas y niños a quienes tienen catorce años o menos y adolescentes a las y los que tienen quince años o más y menos de diecinueve años.

⁴ En 2015, las niñas y niños representaron el 25.85% de los habitantes de Yucatán; en tanto que las y los adolescentes representaron el 8.94%, porcentajes levemente mayores a los estimados para 2020.

nivel estatal ha sido ascendente (Ver Gráfica 3). **En 2018, Yucatán tuvo una TEF de 1.66 nacimientos por cada mil niñas de esa edad, cifra por arriba del promedio nacional de 1.62.** Cabe enfatizar que, en el mismo año, los seis municipios de Yucatán, con las TEF más altas en niñas de 10 a 14 años fueron: Tekal de Venegas, Sudzal, San Felipe, Temax, Telchac Puerto y Chacsinkín. Tales municipios presentan tasas entre nueve y siete veces mayores que el promedio estatal.

Gráfica 3. Municipios de Yucatán con las más altas Tasas Específicas Fecundidad en niñas de 10 a 14 años, 2018.



Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI (2019) Nacimientos registrados por Entidad y municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento, 2018; y Conapo (2018) Proyecciones de la Población a mitad de año de las Entidades y de los Municipios de México, 2015-2030.

El embarazo, parto y puerperio en niñas de 10 a 14 años implica un grave riesgo para su salud y para la salud del bebé. En 2014, la tasa de morbilidad hospitalaria por hipertensión gestacional, preclamsia y diabetes mellitus gestacional fue de 17 por cada cien mil niñas entre 12 y 14 años (INEGI, 2017). Asimismo, la carga de enfermedad por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio representó 1.3% del total de los años de vida saludable perdidos entre las niñas de 10 a 14 años (INEGI, 2017). Además, entre 2010 y 2014, el grupo de niñas entre 10 y 14 años fue el que registró la mayor tasa de hijos con bajo (1500 – 2500g) y muy bajo (<1500g) peso al nacer, así como las mayores tasas de partos prematuros (<37 semanas de gestación) y muy prematuros (28 a 32 semanas) en comparación con las adolescentes mayores de 15 y las jóvenes mayores de 20 (Urbina-Fuentes, Jasso-Gutiérrez, Schiavon-Ermani, Lozano y Finkelman, 2017).

Gráfica 4. Tasa Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 años⁵.



Fuente: Departamento de Generación de Estadísticas de Natalidad y Nupcialidad. Subdirección de Estadísticas Vitales. Dirección General de Estadística. INEGI; Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas. Consejo Nacional de Población (Conapo).

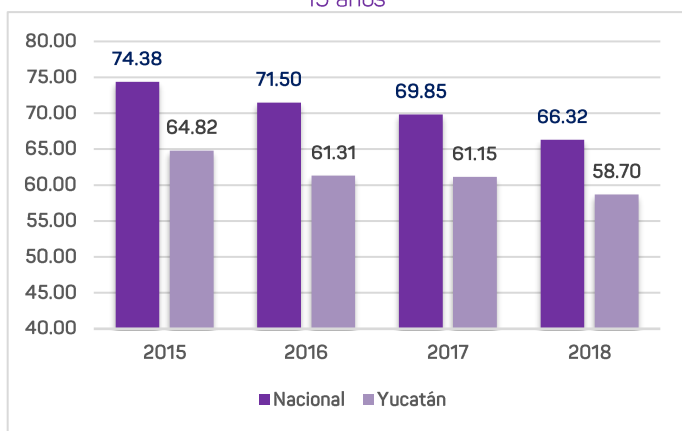
Con respecto al embarazo en adolescentes, de entre 15 y 19 años, es importante señalar que, en 2014, México ocupó el segundo lugar en cuanto a altas tasas de fecundidad en adolescentes respecto a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017); **una quinta parte de los nacimientos en México son de adolescentes embarazadas, el doble de la proporción mundial** (IPAS, 2018).

La TEF en adolescentes de 15 a 19 años, entre 2015 y 2018, presentó una tendencia descendente tanto a nivel nacional como a nivel estatal (Ver Gráfica 5). **En 2018, Yucatán tuvo una TEF de 58.7 nacimientos por cada mil niñas de esa edad; cifra por debajo del promedio nacional de 66.32 nacimientos.** Los municipios con las TEF más altas en adolescentes de 15 a 19 años fueron: Xocchel, Tahdziú, Tepakán, Sudzal, Temax y Homún; cabe enfatizar que **Sudzal y Temax tienen altas TEF tanto en niñas como en adolescentes.**

⁵ Los cálculos de los años 2017 y 2018 fueron elaborados por la Semujeres, en el mes de enero de 2020, con base en información de las proyecciones poblacionales a mitad de año, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050, del Conapo y Nacimientos del INEGI.

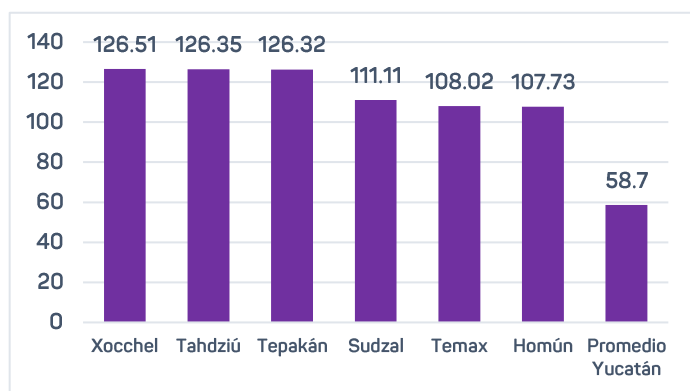
En 2014, la tasa de morbilidad hospitalaria por hipertensión gestacional, preclamsia y diabetes mellitus gestacional fue de 261 por cada cien mil adolescentes entre 15 y 19 años (INEGI, 2017). Asimismo, la carga de enfermedad por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio representó 1.8% del total de los años de vida saludable perdidos entre las niñas de 15 a 19 años (INEGI, 2017).

Gráfica 5. Tasa Específica de Fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años⁶



Fuente: Departamento de Generación de Estadísticas de Natalidad y Nupcialidad. Subdirección de Estadísticas Vitales. Dirección General de Estadística. INEGI; Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas. Consejo Nacional de Población (Conapo).

Gráfica 6. Municipios de Yucatán con las más altas Tasas Específicas de Fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, 2018.



Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI (2019) Nacimientos registrados por Entidad y municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento, 2018; y Conapo (2018) Proyecciones de la Población a mitad de año de las Entidades y de los Municipios de México, 2015-2030.

A nivel mundial, el riesgo de morbilidad asociada a las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio es dos veces mayor entre mujeres de 15 y 19 años que entre aquellas que se embarazan después de los 20 años (IPAS, 2018). En 2017, en México, las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o puerperio fueron la sexta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años (INEGI, 2015b).

Asimismo, la carga de enfermedad por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio representó 1.8% del total de los años de vida saludable perdidos entre las niñas de 15 a 19 años (INEGI, 2017).

III. EDUCACIÓN

Mayores niveles de escolaridad en las mujeres están asociados con la postergación del matrimonio o unión y la maternidad; asimismo, se puede afirmar que los bajos niveles de escolaridad están asociados a mayor prevalencia de embarazos adolescentes (Stern, 1997, p.141). Por lo tanto, resulta importante monitorear el acceso de las niñas y adolescentes a mayores niveles de escolaridad.

En 2018, Yucatán fue la entidad número trece entre las 32 entidades de México considerándolas por mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia por rezago educativo; es decir, que no asisten a un centro de educación formal ni cuentan con la educación básica obligatoria. El porcentaje para Yucatán es de 8.04%, el cual es mayor que el promedio nacional de 7.71%.

A nivel nacional, con respecto a la eficiencia terminal en el periodo 2017 – 2018, las mujeres mostraron mejores tasas de egreso en primaria, secundaria y educación media superior. Sin embargo, cabe señalar que conforme se avanza en los niveles educativos la eficiencia terminal tanto de hombres como de mujeres se va reduciendo. En Yucatán, en el mismo periodo, las mujeres presentaron mayores porcentajes de eficiencia que el promedio nacional, no obstante, estos porcentajes reducen conforme aumenta el nivel escolar, y además, son mayores en mujeres que en hombres; **la mayor brecha por género se mostró en el nivel media superior**, de tal modo que **la entidad se colocó en el lugar 14 entre las entidades con mayor eficiencia terminal entre mujeres en este nivel educativo y en el lugar 17 entre hombres y mujeres en este mismo nivel educativo.**

⁶ Los cálculos de los años 2017 y 2018 fueron elaborados por la Semujeres, en el mes de enero de 2020, con base en información de las proyecciones poblacionales a mitad de año, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050, del CONAPO y Nacimientos del INEGI.

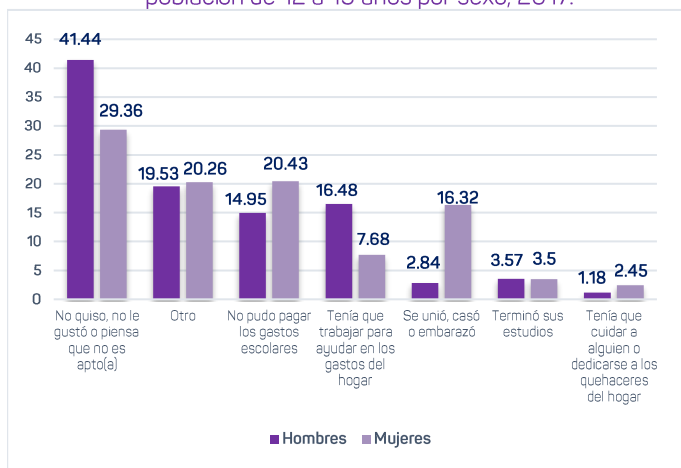
Tabla 2. Porcentaje de eficiencia terminal en Yucatán, ciclo escolar 2017-2018.

Nivel educativo	Nacional	Yucatán		
	Promedio general	Promedio general	Promedio Mujeres	Promedio hombres
Primaria	97.46	100.58	101.03	100.16
Secundaria	86.03	85.52	89.41	81.79
Media Superior	63.88	64.64	69.77	59.77

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en la Encuesta Nacional de Discriminación, 2017. En: Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.

En el periodo 2017-2018, tanto a nivel nacional como en Yucatán, las mujeres presentaron también menores tasas de abandono escolar, en los tres niveles educativos, que los hombres. Sin embargo, es importante señalar que las razones del abandono escolar varían cuando se toma en cuenta el género de las y los estudiantes. A nivel nacional, la razón que presentó la mayor brecha de diferencia entre hombres y mujeres fue abandono escolar por unión, matrimonio o embarazo, con el 16.32% de las mujeres que abandonaron la escuela lo hicieron por ese motivo, en contraste con el 2.84% de los hombres. La segunda razón que presentó mayor diferencia entre hombres y mujeres fue el abandono escolar por falta de gusto o por la percepción de que no se es apta (o), donde el 41.4% de los hombres que abandonaron la escuela lo hicieron por tal motivo, en contraste con el 29.36% de las mujeres. La tercera razón fue el abandono escolar para trabajar y apoyar en los gastos de hogar; el 16.48% de los hombres abandonaron la escuela por ese motivo, en contraste con el 7.68% de las mujeres.

Gráfica 7. Razones de abandono escolar, a nivel nacional, de la población de 12 a 19 años por sexo, 2017.



Fuente: Estimaciones del Conapo con base en la Encuesta Nacional de Discriminación, 2017. En: Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.

Aunado a las razones por las cuales las mujeres abandonan la escuela, se puede observar que en el ciclo escolar 2017-2018, el mayor porcentaje de abandono entre las mujeres de Yucatán fue en el nivel media superior, y donde se mostró una mayor brecha por género. En este periodo, **Yucatán se ubicó en la posición 20 entre las entidades con mayor abandono escolar en mujeres del nivel media superior y en el lugar 17 entre las entidades con mayor abandono escolar en hombres y mujeres en el mismo nivel educativo.**

Tabla 1. Porcentaje de abandono escolar en Yucatán, ciclo escolar 2017-2018.

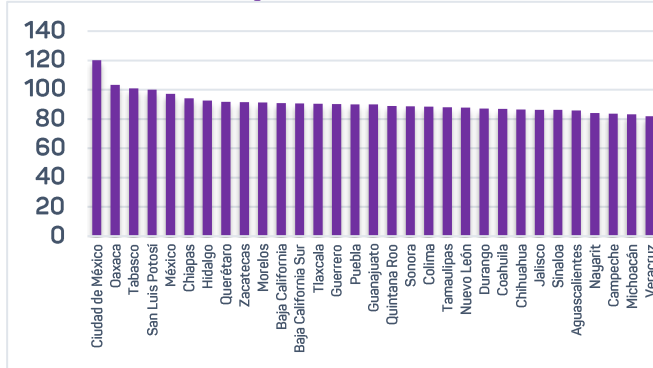
Nivel educativo	Nacional	Yucatán		
	Promedio general	Promedio general	Promedio Mujeres	Promedio hombres
Primaria	0.51	0.3	0.07	0.51
Secundaria	4.57	4.59	3.32	5.82
Media Superior	14.45	13.90	11.52	16.26

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en la Encuesta Nacional de Discriminación, 2017. En: Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.

Con respecto a la educación sexual que reciben las niñas, niños y adolescentes, cabe enfatizar que de las 32 entidades de México, **Yucatán se encontró, en 2018, en el último lugar respecto al porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral en sexualidad**; el 81.6% de las y los estudiantes reportan haber recibido educación integral en sexualidad. Cabe señalar que entre el 2015 y el 2018, el incremento en dicho porcentaje ha sido únicamente de poco más de un punto porcentual. Asimismo, es importante señalar que a nivel nacional, el porcentaje del personal educativo de educación básica que ha recibido formación para la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual y convivencia escolar en los ambientes de aprendizaje escolar, en 2018, fue apenas del 6.9%.

La importancia de fomentar mayores niveles de escolaridad, en general, y educación sexual integral y de calidad, en particular, radica en que las y los adolescentes puedan tener un mejor cuidado de su salud sexual y reproductiva. Además, a mayor escolaridad las mujeres tienden a posponer la maternidad, reducir el número de hijos y aumentar su participación económica extra-doméstica (Paez Domínguez, 2017); en tanto que los hombres tienden a aumentar su participación en el cuidado infantil y a fomentar relaciones de pareja con una distribución más equitativa del trabajo de cuidado (García y Pacheco, 2014).

Gráfica 8. Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral en sexualidad, 2018.



Fuente: Estadística educativa, Secretaría de Educación Pública. Estimaciones de población, Consejo Nacional de Población. En: Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.

IV. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En 2012, a nivel nacional y estatal, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años que ya iniciaron su vida sexual activa fue de 12.5% y 11.9%, respectivamente. La edad promedio en la que las mujeres menores a 19 años, en Yucatán, tuvieron su primera relación sexual fue 15.8 años, ligeramente por arriba del valor nacional de 15.7 años. Si bien el inicio de la vida sexual de las niñas, niños y adolescentes es un factor a considerar en el embarazo infantil y adolescente, resulta de mayor importancia / relevancia monitorear el acceso que tienen a educación sexual integral y de calidad, a métodos anticonceptivos, atención médica adecuada y a los contextos de violencia en los que viven.

En el 2012, en Yucatán, el 70.2% de las niñas, niños y adolescentes, de 12 a 19 años, que reportaron haber tenido relaciones sexuales indicó que empleó cuando menos un método anticonceptivo en la primera y última relación sexual. Ese año, Yucatán se ubicó en el sexto lugar respecto a las entidades con mayor proporción de niñas, niños y adolescentes que reportan haber hecho un uso consistente de anticonceptivos.

Sin embargo, en 2018, tanto a nivel nacional como en el caso de Yucatán, 59.4% y 58.6%, respectivamente, de las mujeres de entre 15 y 49 años sexualmente activas no utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual (INEGI 2018). Asimismo, en 2018, el 26.35% de las mujeres de 15 a 24 años sexualmente activas, en Yucatán, reportó tener una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos; porcentaje por arriba del promedio nacional de 22.33%. Así, **en 2018, Yucatán ocupó el noveno lugar respecto a las entidades con mayor porcentaje de mujeres**

Insatisfechas en cuanto al acceso de métodos anticonceptivos.

En lo referente a las infecciones de transmisión sexual (ITS)⁷, para 2018, el estado de Yucatán registró una incidencia de 32 casos de mujeres de 10 a 19 años con ITS por cada cien mil mujeres, por debajo del valor nacional de 46.3.

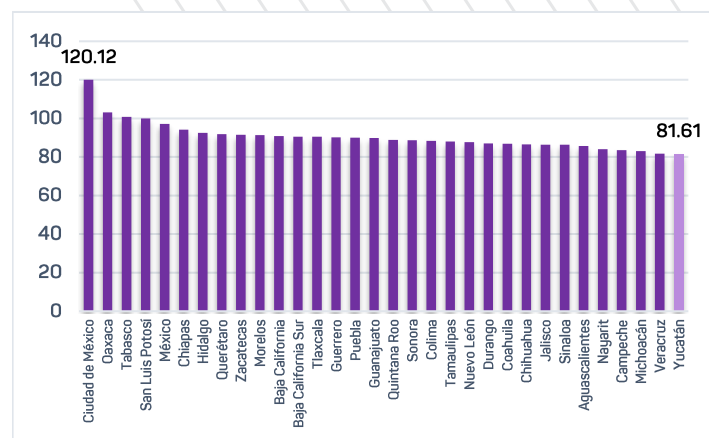
Gráfica 9. Incidencia registrada de ITS en mujeres de 10 a 19 años, 2018. (Por cada cien mil mujeres)



Fuente: SS/Dirección General de Epidemiología, Sistema Único de Información y Vigilancia Epidemiológica. Datos al cierre de cada año. SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Versión Censo 2010.

Si comparamos al estado con las 32 entidades federativas, se observa que Yucatán ocupó el lugar 26 entre las entidades con mayor incidencia de ITS en mujeres; los estados con mayor incidencia fueron Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.

Gráfica 10. Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral en sexualidad, 2018.



Fuente: SS/Dirección General de Epidemiología, Sistema Único de Información y Vigilancia Epidemiológica. Datos al cierre de cada año. SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Versión Censo 2010.

⁷ Incluye chancro blando, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma por clamidias, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital e infección por VPH.

Con respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violencia sexual, cabe mencionar que la Norma Oficial Mexicana “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” (NOM-046-SSA2-2005) considera los casos de violación como urgencias médicas que requieren atención inmediata y establece la obligación a las instituciones públicas de salud de prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea producto de una violación.

Entre el 2012 y el 2019, a nivel nacional se reportaron⁸ 442 ILE en hospitales públicos del IMSS, ISSSTE o de la Secretaría de Salud; de ellas, la mayoría fueron niñas y adolescentes de 10 a 15 años (Amezcuza y Peralta, 2020). Asimismo, de manera más concreta, entre 2012 y 2017, a nivel nacional se reportaron⁹ 137 ILE por violación en instituciones de salud federales y locales, así como procuradurías de justicia, de las cuales 52 corresponden a menores de edad (GIRE, 2018, p.56). En ese periodo de tiempo, Yucatán reportó únicamente un caso de ILE por violación.

La ILE, a pesar de su importancia fundamental para garantizar el desarrollo de las niñas y adolescentes que sufrieron un embarazo por violación, es una intervención pública que, en múltiples entidades, carece de los componentes mínimos de planeación, así como de asignación de recursos (CNDH, 2017, p.83). La falta de registro y seguimiento institucional puede dar pie a que las ILE por violación se estén realizando fuera del sistema público con grandes riesgos de salud para las mujeres, adolescentes y niñas. En 2019, el aborto fue la tercera causa de muerte materna a nivel nacional, con una razón de mortalidad de 2.8 por cada mil nacimientos estimados. En Yucatán, entre 2008 y 2015 únicamente se reportaron 11 defunciones maternas que tuvieron como causa “embarazo terminado en aborto”, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (INEGI, 2018).

V. VIOLENCIA SEXUAL

El embarazo infantil constituye una grave consecuencia de la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Considerando que las niñas, entre los 10 y 14 años, no cuentan con la madurez intelectual y emocional para decidir sobre su vida sexual y reproductiva se puede argumentar que el principal factor asociado a su ocurrencia es la violencia sexual (GIPEA, 2020, p.34).

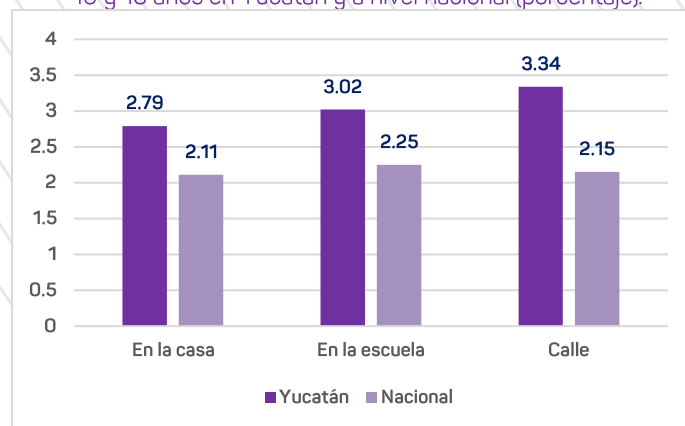
⁸ Solicitudes de transparencia para el reportaje “El aborto legal en México tras una violación es un camino tortuoso” (Amezcuza y Peralta 2020).

⁹ Solicitudes de transparencia para el reportaje “La pieza faltante. Justicia Reproductiva” (GIRE 2018).

A nivel nacional, de las mujeres que pasaron por una situación de violación en la infancia y reportaron un embarazo adolescente; 8 de cada 10 fueron atacadas por sus familiares y 5 de cada 10 fueron atacadas por vecinos o miembros de su comunidad (GIRE, 2018, p.17). En 2016, en México, 9.4% de las mujeres de 15 años y más reportaron haber vivido violencia sexual en su infancia; siendo los principales agresores los tíos (19.7%), miembros del ámbito comunitario (16%) y los primos (14.2%) (INEGI, 2016b).

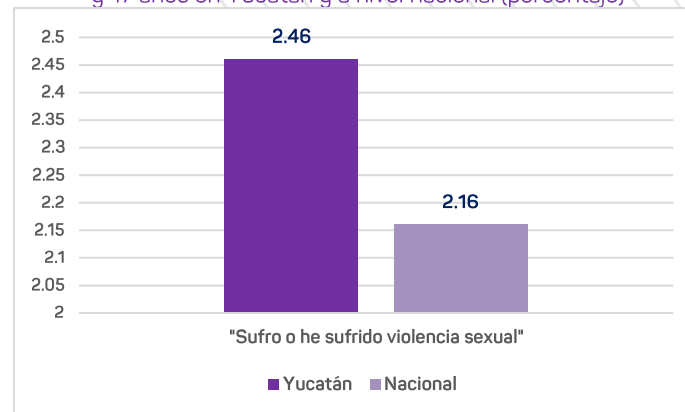
Respecto a la prevalencia de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, en Yucatán el 2.79% de niñas entre 10 y 13 años reportan haber vivido o que actualmente viven violencia sexual dentro del hogar, el 3.02% en la escuela y el 3.32% en la calle; en el caso de las adolescentes entre 14 y 17 años, el 2.46% actualmente vive o ha vivido violencia sexual (INE, 2015).

Gráfica 11. Prevalencia de violencia sexual y ámbito en niñas entre 10 y 13 años en Yucatán y a nivel nacional (porcentaje).



Fuente: estimaciones propias con base en la Consulta Infantil y Juvenil 2015, Resultados por Entidad, municipio y sexo. Instituto Nacional Electoral.

Gráfica 12. Prevalencia de violencia sexual en adolescentes entre 14 y 17 años en Yucatán y a nivel nacional (porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con base en la Consulta Infantil y Juvenil 2015, Resultados por Entidad, municipio y sexo. Instituto Nacional Electoral.

En 2012, Yucatán ocupó el tercer lugar respecto a las mayores tasas de relaciones asimétricas en la primera relación sexual de niñas, niños y adolescentes; es decir, el 36% de las niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años que reportaron haber tenido relaciones sexuales antes de los 15 años indicaron que su primera relación sexual fue con una pareja de mayor edad. Adicionalmente, en 2016, tanto a nivel nacional como en el caso de Yucatán, un 3% de las mujeres de 15 años y más reportó que su primera relación sexual fue sin consentimiento (INEGI 2016b).

Un factor asociado de manera importante al embarazo en la infancia y adolescencia son las uniones y matrimonios infantiles. En 2015 se reformó el Código de Familia del Estado de Yucatán para eliminar la posibilidad de que menores de 18 años puedan contraer matrimonio, en armonización con el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; esto implicó un avance importante, tal y como reflejan las estadísticas de matrimonios en Yucatán.

En 2009, se realizaron 1,694 matrimonios con niñas y adolescentes menores de 18 años, de los cuales el 82.3% fueron con un hombre entre los 18 y 44 años. Sin embargo, tras la reforma de 2015, disminuyó drásticamente el número de matrimonios con adolescentes menores de edad, registrándose en 2016 una reducción del 99.75%, con solo un matrimonio entre una adolescente de 16 años y un hombre de 21 años, mientras que en 2017 y 2018 no se registraron casos. Sin embargo, es importante señalar que las menores de edad aún corren riesgo de ver vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos cuando se ven involucradas en uniones. En 2018, el 19.42% de las mujeres entre 20 y 24 años en Yucatán afirmó que se casó o unió antes de cumplir la mayoría de edad (INEGI, 2018).

VI. OPORTUNIDADES LABORALES

Ante un contexto de fuerte desigualdad social, una parte no menor de la población adolescente escolarizada tiene bajas expectativas respecto a los retornos y oportunidades futuras que les puede brindar una mayor cantidad de años de estudio (Rodríguez Vignoli, 2012). Al abandonar los estudios e insertarse al trabajo generalmente lo hacen a empleos poco calificados con salarios precarios, debido a que no cuentan con las habilidades y capacidades para desarrollar un trabajo calificado. Por tales motivos, resulta pertinente monitorear el acceso de adolescentes en edad legal.

de trabajar a oportunidades laborales al mismo tiempo que cursan la educación obligatoria (GIPEA, 2020, P.95).

En 2018, la tasa de desocupación de la población de 15 a 19 años en Yucatán fue de 3.76%, poco más de tres puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de 6.97; **la entidad ocupó el quinto lugar respecto a las menores tasas de desocupación;** sin embargo, es importante enfatizar que, en 2018, la tasa de informalidad laboral de la población ocupada de 15 a 19 años en Yucatán fue del 88.57%. **La entidad se ubicó en el lugar trece respecto a las entidades con mayores tasas de informalidad laboral entre adolescentes,** siendo Oaxaca la entidad con mayor tasa (97.38%) y Nuevo León el estado con la menor tasa (59.28%).

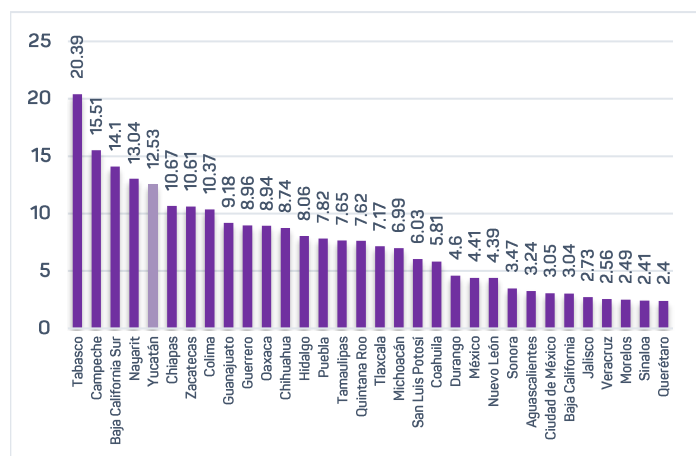
Mapa 1. Tasa de informalidad laboral de la población ocupada de 15 a 19 años, 2018.



Fuente: INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA

A su vez, es importante señalar que, **en 2018, el 63.19% de las y los adolescentes de 15 a 19 años ocupados en Yucatán no asistió a la escuela,** porcentaje ligeramente por arriba del promedio nacional de 62.9%; **la entidad se ubicó así en el lugar 14 respecto a las entidades con mayores tasas de población ocupada que no asistió a la escuela.** Además, en Yucatán, en 2017, un 14.87% de las y los niños y adolescentes ocupados se desempeñaron en actividades económicas que no están permitidas por la Ley Federal del Trabajo puesto que ponen en riesgo su salud, o bien, afectan su desarrollo. Asimismo, en 2017, un 12.53% de la población de 10 a 17 años en Yucatán desempeñó quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. En ese sentido, **Yucatán se ubicó en el quinto lugar respecto a las entidades con mayores tasas de niñas, niños y adolescentes que realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas,** poco más de seis puntos porcentuales por arriba del promedio nacional de 6.35%.

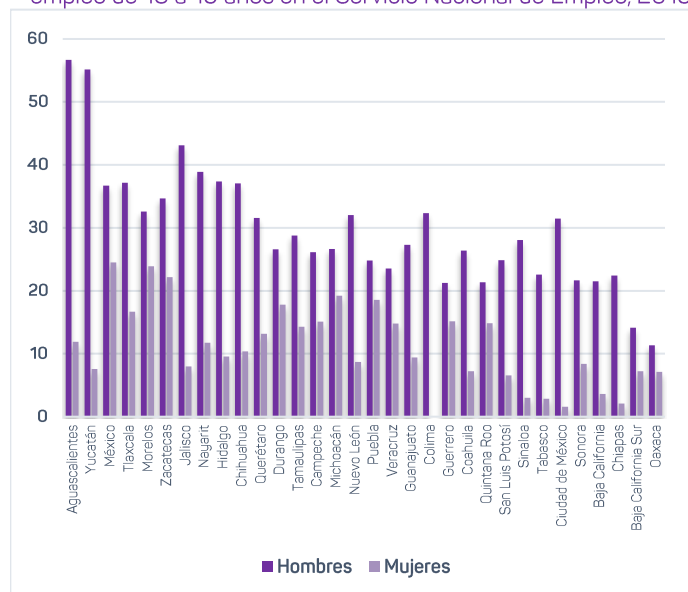
Gráfica 13. Tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas para la población de 10 a 17 años, 2017.



Fuente: INEGI-STPS, Módulo de Trabajo Infantil. En: Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.

En 2019, con respecto al porcentaje de adolescentes buscadores de empleo, de 16 a 19 años, que se colocaron a través de los programas y estrategias del Servicio Nacional de Empleo (Bolsa de trabajo, Ferias de empleo, Subprograma Bécate y Subprograma Fomento al Autoempleo), Yucatán ocupó el segundo lugar entre las entidades con mejor tasa de colocación, con una tasa promedio de 34.62%. Cabe señalar que, en todas las entidades, los hombres tienen una mejor tasa de colocación que las mujeres; **Yucatán fue la onceava entidad con las menores tasa de colocación entre mujeres**, con 7.59% de mujeres adolescentes que lograron colocarse mediante el Servicio Nacional de Empleo, en contraste con el 55.14% de los hombres.

Gráfica 14. Tasa de colocación de adolescentes buscadores de empleo de 16 a 19 años en el Servicio Nacional de Empleo, 2019.



Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Servicio Nacional de Empleo. En: Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Fortalezas

- En 2019, Yucatán ocupó el segundo lugar entre las entidades con mejor tasa de colocación de adolescentes buscadores de empleo mediante los programas del Servicio Nacional de Empleo.
- En el periodo 2017-2018, tanto a nivel nacional como en Yucatán las mujeres presentaron menores tasas de abandono escolar que los hombres, en los tres niveles educativos.

Oportunidades

- En el 2012, en Yucatán, el 70.2% de las niñas, niños y adolescentes, de 12 a 19 años, que reportaron haber tenido relaciones sexuales indicó que empleó cuando menos un método anticonceptivo en la primera y última relación sexual.
- En 2018, Yucatán ocupó el quinto lugar respecto a las entidades con menores tasas de desocupación en la población de 15 a 19 años.

Debilidades

- En 2018, Yucatán se ubicó en el último lugar, entre las 32 entidades de México, respecto al porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral en sexualidad.
- En 2018, Yucatán ocupó el noveno lugar respecto a las entidades con mayor porcentaje de mujeres insatisfechas en cuanto al acceso a métodos anticonceptivos.
- Existe una falta de registros de información sobre la implementación de la NOM-046-SSA2-2005.
- Yucatán, en 2018, se ubicó en el lugar trece respecto a las entidades con mayores tasas de informalidad laboral entre adolescentes.
- En 2019, en Yucatán existió una brecha de colocación que desfavoreció a las mujeres buscadoras de empleo mediante el Servicio Nacional de Empleo.

Amenazas

- En 2018, en Yucatán, el 58.6% de las mujeres, entre 15 y 49 años, sexualmente activas afirmó no haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.
- En 2012, Yucatán ocupó el tercer lugar respecto a las mayores tasas de relaciones asimétricas en la primera relación sexual de niñas, niños y adolescentes.
- En 2018, el 19.42% de las mujeres entre 20 y 24 años en Yucatán afirmó que se casó o unió antes de cumplir la mayoría de edad.
- La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) en niñas de 10 a 14 años, en Yucatán, durante el 2018, fue de 1.66 nacimientos por cada mil niñas de esa edad; los seis municipios de Yucatán con las más altas TEF en niñas en 2018 presentan tasas entre nueve y siete veces mayores que el promedio estatal.
- La TEF en adolescentes entre 15 y 19 años, en Yucatán, durante el 2018, fue de 58.7 nacimientos por cada mil niñas de esa edad; los seis municipios de Yucatán con las más altas TEF en adolescentes prácticamente duplican el promedio de la entidad.



¿DÓNDE SE QUIERE ESTAR? ¿QUÉ SE HARÁ PARA LOGRARLO?

En la formulación del Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se observaron criterios de pertinencia en el diagnóstico y árbol de problemas. Con base en estos hallazgos, se determinaron dos temas estratégicos para atender los problemas identificados. El primero, ***Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes***, busca ampliar las oportunidades educativas de niñas, niños y adolescentes, disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva.

El segundo, ***Autonomía, curso y proyecto de vida***, busca facilitar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes sean capaces de tomar decisiones autónomas y responsables sobre sus propias vidas, en particular en cuanto a lo relacionado con sus derechos sexuales y reproductivos.

En el diseño del Programa, se formaron objetivos acordes a la disponibilidad de los recursos humanos, financieros y materiales, los cuales se identifican en la implementación del ciclo presupuestario. Las líneas de acción planteadas, focalizan los esfuerzos de la Administración Pública Estatal en realizar acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y, consideran las medidas necesarias en el marco de la contingencia ante el COVID-19.

A continuación, se presentan los objetivos, estrategias y líneas de acción:

Temas estratégicos



I. **Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.**

Objetivo 1.1. Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.

Estrategia 1.1.1. Fomentar esquemas educativos integrales, inclusivos y flexibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes, que les permita concluir la educación obligatoria.

Líneas de acción

1.1.1.1. Promover mecanismos para la reincorporación escolar de niñas, niños y adolescentes con énfasis en las necesidades específicas de zonas rurales e indígenas.

1.1.1.2. Proporcionar apoyos para la inclusión, permanencia y conclusión de los estudios para la reducción de los costos de asistir a la escuela.

1.1.1.3. Desarrollar actividades que generen actitudes, cuidados a la salud, habilidades para la vida y de orientación vocacional en educación básica y media superior.

1.1.1.4. Facilitar la profesionalización y capacitación del personal docente en temas de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género, autonomía y habilidades para la vida.

Estrategia 1.1.2. Favorecer la educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva.

Líneas de acción

1.1.2.1. Diseñar contenidos de educación Integral de la sexualidad, con énfasis en salud sexual, salud reproductiva y de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

1.1.2.2. Desarrollar procesos permanentes de capacitación y formación para el personal docente en la enseñanza de contenidos de educación integral en sexualidad.

1.1.2.3. Facilitar el establecimiento de vínculos escolares con el entorno comunitario y familiar para la promoción de la educación integral en sexualidad, derechos humanos, género e interculturalidad.

1.1.2.4. Estimular procesos de aprendizaje sobre sexualidad, género y violencias contra las niñas y adolescentes mujeres a través de actividades artísticas en espacios comunitarios.

Estrategia 1.1.3. Impulsar la igualdad de oportunidades educativas para las niñas y adolescentes en situación de embarazo, así como para las niñas y adolescentes madres en el nivel básico y medio superior.

Líneas de acción

1.1.3.1. Promover la entrega de becas educativas a las niñas y adolescentes madres o en situación de embarazo que habiten en comunidades indígenas y que se encuentren en los municipios identificados como prioritarios.

1.1.3.2. Facilitar el establecimiento de modalidades de estudio que permitan la formación en educación básica de niñas madres y en situación de embarazo.

1.1.3.3. Promover mecanismos educativos especiales de alfabetización que permitan la regularización de niñas y adolescentes madres en planteles de educación secundaria y de educación media superior.

1.1.3.4. Desarrollar mecanismos interinstitucionales para garantizar la permanencia escolar de las madres adolescentes y estudiantes en situación de embarazo, en un ambiente de igualdad, inclusión y no discriminación.

Objetivo 1.2. Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes.

Estrategia 1.2.1. Implementar acciones para la detección y prevención oportuna de la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

1.2.1.1. Generar acciones para la detección, canalización y denuncia de los casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes con especial atención en las zonas rurales, indígenas, urbano marginadas, de contexto migrante y en municipios priorizados.

1.2.1.2. Ejecutar acciones de difusión en municipios y comisarías para que la población detecte y denuncie las violencias en contra de niñas y adolescentes, con mayor énfasis en el tipo sexual y sus nuevas modalidades, como la digital.

1.2.1.3. Poner en marcha la difusión de herramientas para detectar la pornovenganza, el ciberacoso sexual, abuso sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes y a la sociedad en general.

1.2.1.4. Desarrollar capacitaciones y procesos formativos dirigidos a hombres jóvenes, adolescentes y niños sobre masculinidades alternas en la corresponsabilidad del ejercicio de la sexualidad.

1.2.1.5. Implementar acciones de difusión en maya y español para difundir la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, Criterios para la Prevención y Atención.

Estrategia 1.2.2 Favorecer los servicios especializados en la atención a la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes.

1.2.2.1. Reforzar el trabajo coordinado con las autoridades municipales para brindar servicios de detección de violencia sexual y atención integral y especializada en espacios comunitarios para niñas, niños y adolescentes.

1.2.2.2. Formular una ruta institucional para denuncias y atenciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, por jurisdicción de los municipios de Yucatán.

1.2.2.3. Promover la capacitación continua de los equipos de atención primaria a la salud para la detección del abuso sexual.

1.2.2.4. Proporcionar los servicios de profilaxis, de anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por normatividad vigente, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima de violencia sexual.

1.2.2.5. Capacitar a personal clave estatal y municipal en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, Criterios para la Prevención y Atención.

Estrategia 1.2.3. Impulsar acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia sexual.

Líneas de acción

1.2.3.1. Establecer medidas de protección especializadas de niñas, niños y adolescentes en los procesos de intervención jurídica, principalmente durante la etapa de identificación y persecución penal de las personas acusadas de violación.

1.2.3.2. Proporcionar procesos de contención emocional para las personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia sexual.

1.2.3.3. Promover la capacitación en normativas como la NOM-046-SSA2-2005 al personal del servicio público responsable de programas vinculados con la prevención y asistencia a las víctimas de violencia sexual.

1.2.3.4. Facilitar vínculos con las Casas Hogar para la realización de acciones coordinadas que permitan la detección oportuna de situaciones de violencia sexual en infantes y adolescentes.

1.2.3.5. Supervisar la atención integral y el respeto estricto de los derechos humanos de infantes y adolescentes que se encuentran en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE).

Objetivo 1.3. Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes.

Estrategia 1.3.1. Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.

Líneas de acción

1.3.1.1. Ampliar la cobertura de los servicios amigables de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes, asegurando una atención igualitaria, aceptable, accesible y efectiva.

1.3.1.2. Fortalecer la capacidad institucional de los servicios que se brindan a los Hospitales Comunitarios para responder a las necesidades relacionadas con la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en niñas y adolescentes madres.

1.3.1.3. Promover vínculos interinstitucionales con escuelas, centros de salud, farmacias y programas de gobierno que se implementen a nivel municipal para promover los servicios de salud sexual reproductiva a la ciudadanía y priorizando en las y los adolescentes.

1.3.1.4. Poner en marcha un programa de salud sexual y reproductiva que se implemente a través de los Hospitales Comunitarios y que otorgue servicios clínicos al grupo etario de 10 a 19 años, con sustento en el marco normativo y regulatorio para otorgar servicios de salud sexual y reproductiva.

1.3.1.5. Proporcionar a la población adolescente información sobre los servicios del sector salud, de las organizaciones de la sociedad civil y de las farmacias u otros espacios vinculados.

1.3.1.6. Promover la formación de adolescentes y jóvenes como promotoras y promotores de la salud sexual y reproductiva en sus comunidades.

Estrategia 1.3.2. Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).

Líneas de acción

1.3.2.1. Promover mecanismos de difusión en los municipios del estado sobre salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, género e interculturalidad y sobre la gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).

1.3.2.2. Diseñar esquemas novedosos para la oferta y el suministro de métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, por medio de diferentes esquemas de provisión de fijos o itinerantes, dentro y fuera de las instituciones de salud, para las y los adolescentes.

1.3.2.3. Facilitar la implementación de dispensadores públicos de condones femeninos y masculinos en instancias educativas, centros de salud y en lugares estratégicos y al alcance de las y los adolescentes.

1.3.2.4. Reforzar la calidad de la consejería brindada a adolescentes en el primer y segundo nivel de atención.

1.3.2.5. Capacitar al personal médico y profesionales en los servicios de salud en temas de salud sexual y reproductiva, perspectiva de las juventudes y género, desde una visión laica e intercultural.

1.3.2.6. Brindar información sobre métodos anticonceptivos a niñas y adolescentes madres y en situación de embarazo, en los diferentes momentos de contacto (consulta prenatal, parto, puerperio y control de la niña y niño sano).

1.3.2.7. Establecer mecanismos para asegurar que las y los adolescentes accedan a la gama completa de métodos anticonceptivos sin trámites complejos, en pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.

Temas estratégicos



II. Autonomía, curso y proyecto de vida.

Objetivo 2.1. Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables.

Estrategia 2.1.1. Impulsar las acciones culturales y deportivas en las niñas, niños y adolescentes para favorecer su curso y proyecto de vida.

Líneas de acción

2.1.1.1. Crear redes de fomento al liderazgo y la participación ciudadana, compuestas por jóvenes en comunidades de los municipios del estado.

2.1.1.2. Facilitar talleres y espacios comunitarios sobre arte y cultura dirigidos a las niñas, niños y adolescentes en municipios y comisarías.

2.1.1.3. Promover la práctica deportiva y activación física, libre de estereotipos e incluyente, dirigida niñas, niños y adolescentes en escuelas, parques y espacios comunitarios en los municipios del estado.

2.1.1.4. Proporcionar becas de apoyo al deporte a niñas y adolescentes madres para promover la permanencia en la formación deportiva.

Estrategia 2.1.2. Impulsar la ocupación de adolescentes en edad legal para trabajar acorde a sus capacidades para el diseño de su proyecto de vida.

Líneas de acción

2.1.2.1. Poner en marcha talleres de capacitación para el empleo y autoempleo de las y los adolescentes en edad legal de trabajar.

2.1.2.2. Promover la celebración de convenios de coordinación con empresas formales para la contratación de personal adolescente en edad legal de trabajar.

2.1.2.3. Diseñar programas duales de estudio y trabajo dirigidos a adolescentes en edad legal de trabajar.

Objetivo 2.2. Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos.

Estrategia 2.2.1. Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.

Líneas de acción

2.2.1.1. Motivar la participación de las y los adolescentes en los procesos de planeación e implementación de las acciones de gobierno para la prevención del embarazo en adolescentes.

2.2.1.2. Consolidar el Reglamento para el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).

2.2.1.3. Registrar datos desagregados por sexo y edad u otras variables relevantes de los programas de gobierno en torno a la prevención y atención del embarazo en adolescentes.

2.2.1.4. Gestionar convenios de coordinación con escuelas y sociedad civil organizada para realizar acciones conjuntas en la prevención del embarazo en adolescentes.

2.2.1.5. Desarrollar capacitaciones sobre derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos, al personal integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), para el diseño de políticas públicas con perspectiva de juventudes, género e interculturalidad.

2.2.1.6. Generar un sistema de información para el seguimiento de acciones de cumplimiento a los componentes de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), así como las recomendaciones e informes solicitadas por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA).

Estrategia 2.2.2. Impulsar la creación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Líneas de acción

2.2.2.1. Facilitar conocimientos e información sobre derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, dirigidos a personal estratégico de los Ayuntamientos Municipales.

2.2.2.2. Asesorar a los gobiernos municipales en la instalación y operación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

2.2.2.3. Motivar la participación de las y los adolescentes en los procesos de planeación de las acciones de gobierno para la prevención del embarazo en adolescentes a nivel municipal, con especial atención en aquellos municipios que son prioritarios para su intervención.

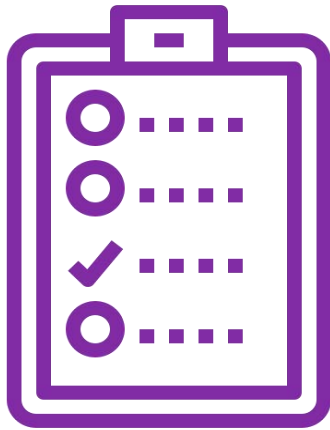
Estrategia 2.2.3. Promover la armonización legislativa en materia de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

2.2.3.1. Difundir la normatividad nacional e internacional que sustenta la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir educación integral de la sexualidad, sin discriminación alguna.

2.2.3.2. Ajustar la normatividad estatal y municipal para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, en alineación con la normatividad nacional e internacional.

2.2.3.3. Analizar el marco jurídico estatal y municipal para identificar los instrumentos que requieren ser armonizados en materia de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.



¿CÓMO SE MEDIRÁ Y EVALUARÁ?

Las fichas técnicas de indicadores, son documentos que contienen un conjunto de elementos que permiten describir de manera sencilla las características que lo conforman para su comprensión, interpretación y reproducción de su cálculo. A continuación, se presentan las fichas técnicas de Indicadores de cada tema estratégico.

Es importante hacer notar, que el avance de los resultados de indicadores a través del marco temporal planeado estará sujeto a criterios de suficiencia presupuestal y aquellas externalidades que se susciten y deriven de fenómenos naturales, ambientales o sanitarias.

Tema estratégico	Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.		
Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.		
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 4, meta 4.5.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de abandono escolar en el nivel media superior.		
Definición	Mide la proporción de alumnas y alumnos matriculadas que abandonan la escuela de un periodo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel educativo.		
Descripción	Este indicador permite conocer el abandono escolar de las alumnas y alumnos que se inscribieron en el ciclo escolar; esta información permite determinar en qué rango de edad, las mujeres y hombres suelen interrumpir sus estudios, para dedicarse a otras actividades.		
Tipo de algoritmo	Porcentaje	Periodicidad de cálculo	Anual
Fecha de Referencia	Ciclo escolar 2017-2018	Fecha de actualización	Diciembre 2021
Ficha Técnica de Indicadores			
Fórmula de cálculo	A=A		
Tendencia	Descendente	Dimensión	Eficacia
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento		Secretaría de las Mujeres (Semujeres).	
Variables			
Variable A		Porcentaje de abandono escolar en el nivel media superior.	
Valor	13.90	Unidad de Medida	Porcentaje
Fecha	2017-2018		
Medio de verificación	Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.	Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).
Variable B		NA	
Valor	NA	Unidad de Medida	NA
Fecha	NA		
Medio de verificación	NA	Fuente	NA
Variable C		NA	
Valor	NA	Unidad de Medida	NA
Fecha	NA		
Medio de verificación	NA	Fuente	NA
Línea Base			
Valor	13.90	Unidad de Medida	Porcentaje
Fecha	2017-2018		
Promedio nacional	14.45	Lugar que ocupa el estado	17
Tendencia del Clasificador		Descendente	
Metas			
Meta 2021	13.50	Fecha	Dic 2021
Meta 2024	13.00	Fecha	Dic 2024
Meta 2030	11.00	Fecha	Dic 2030
Criterios de evaluación			
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.	
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.	
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.	

Tema estratégico	Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.		
Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.		
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 4, meta 4.5.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel de educación media superior.		
Definición	Mide la proporción de alumnos y alumnas que logran finalizar la educación media superior en un determinado ciclo escolar, por cada cien alumnas y alumnos de nuevo ingreso inscritos 3 ciclos escolares atrás, que es el total de años ideal o normativo para concluir este nivel educativo.		
Descripción	Este indicador permite conocer la eficacia del sistema educativo en el avance ideal del alumnado, con lo cual se pueden identificar áreas de mejora relacionadas con la equidad y la eficacia del egreso en el tiempo normativo.		
Tipo de algoritmo	Porcentaje	Periodicidad de cálculo	Anual
Fecha de Referencia	Ciclo escolar 2017-2018	Fecha de actualización	Diciembre 2021
Ficha Técnica de Indicadores			
Fórmula de cálculo	A=A		
Tendencia	Ascendente	Dimensión	Eficacia
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento		Secretaría de las Mujeres (Semujeres).	
Variables			
Variable A		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel de educación media superior.	
Valor	64.64	Unidad de Medida	Porcentaje
Fecha	2017-2018		
Medio de verificación	Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.	Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).
Variable B		NA	
Valor	NA	Unidad de Medida	NA
Fecha	NA		
Medio de verificación	NA	Fuente	NA
Variable C		NA	
Valor	NA	Unidad de Medida	NA
Fecha	NA		
Medio de verificación	NA	Fuente	NA
Línea Base			
Valor	64.64	Unidad de Medida	Porcentaje
Fecha	2017-2018		
Promedio nacional	63.88	Lugar que ocupa el estado	17
Tendencia del Clasificador		Descendente	
Metas			
Meta 2021	64.0	Fecha	Dic 2021
Meta 2024	63.5	Fecha	Dic 2024
Meta 2030	60.0	Fecha	Dic 2030
Criterios de evaluación			
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.	
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.	
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.	

Tema estratégico	Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.				
Objetivo	Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes.				
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 5, metas 5.1, 5.3, 5.6. Objetivo 3, metas 3.1, 3.7.				
Nombre del Indicador	Tasa Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 años de edad.				
Definición	Mide la cantidad de nacidos vivos en niñas de 10 a 14 años de edad que ocurren en un año por cada 1000 niñas de 10 a 14 años de edad a mitad de ese mismo año.				
Descripción	Este indicador es auxiliar en la medición de la violencia sexual contra menores de edad, ya que uno de los elementos clave que se han destacado como factores explicativos de la maternidad en niñas menores de 15 años es el abuso sexual. El indicador considera los siguientes criterios: Características del nacimiento: • Año de registro (en automático); • Entidad y municipio de residencia. Características de la madre: • Entidad y municipio de residencia habitual; • Edad al momento del nacimiento.				
Tipo de algoritmo	Tasa	Periodicidad de cálculo	Anual		
Fecha de Referencia	Diciembre 2018	Fecha de actualización	Diciembre 2021		
Ficha Técnica de Indicadores					
Fórmula de cálculo	$A=(B/C)*D$				
Tendencia	Descendente	Dimensión	Eficacia		
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento	Secretaría de las Mujeres (Semujeres).				
Variables					
Variable A	Tasa Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 años de edad.				
Valor	1.66	Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Medio de verificación	Estimación propia con base en: 1/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Nacimientos registrados por Entidad y Municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento. 2/ Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población a mitad de año para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050. Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva.		Fuente	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo).	
Variable B	Total de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años en el periodo t.				
Valor	154	Unidad de Medida	Nacimientos	Fecha	2018
Medio de verificación	Departamento de Generación de Estadísticas de Natalidad y Nupcialidad. Subdirección de Estadísticas Vitales. Dirección General de Estadística.		Fuente	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	
Variable C	Total de niñas entre 10 y 14 años en periodo t.				
Valor	92689	Unidad de Medida	Niñas	Fecha	2018
Medio de verificación	Proyecciones de la Población a mitad de año, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050. Dirección		Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).	
	General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva.				

Variable D		Factor de expansión.			
Valor	1000	Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación	NA		Fuente	NA	
Línea Base					
Valor	1.66	Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Promedio nacional	1.62	Lugar que ocupa el estado		12	
Tendencia del Clasificador	Descendente				
Metas					
Meta 2021	1.58	Fecha	Dic 2021		
Meta 2024	1.55	Fecha	Dic 2024		
Meta 2030	1.50	Fecha	Dic 2030		
Criterios de evaluación					
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.			
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.			
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.			

Tema estratégico	Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.				
Objetivo	Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes.				
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 5, metas 5.1, 5.3, 5.6. Objetivo 3, metas 3.1, 3.7.				
Nombre del Indicador	Tasa Específica de Fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad.				
Definición	Mide la cantidad de nacidos vivos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad que ocurren en un año por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad a mitad de ese mismo año.				
Descripción	Este indicador permite conocer el comportamiento reproductivo de mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad; adicionalmente, uno de los factores explicativos del embarazo en menores de edad es el abuso sexual, por lo que es auxiliar en la medición de la violencia sexual hacia adolescentes. El indicador considera los siguientes criterios: Características del nacimiento: • Año de registro (en automático); • Entidad y municipio de residencia. Características de la madre: • Entidad y municipio de residencia habitual; • Edad al momento del nacimiento.				
Tipo de algoritmo	Tasa	Periodicidad de cálculo	Anual		
Fecha de Referencia	Diciembre 2018	Fecha de actualización	Diciembre 2021		
Ficha Técnica de Indicadores					
Formula de calculo	A=(B/C)*D				
Tendencia	Descendente	Dimensión	Eficacia		
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento	Secretaría de las Mujeres (Semujeres).				
Variables					
Variable A	Tasa Específica de Fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad.				
Valor	58.7	Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Medio de verificación	Estimación propia con base en: 1/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Nacimientos registrados por Entidad y Municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento. 2/ Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población a mitad de año para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050. Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva.		Fuente	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo).	
Variable B	Total de nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años en el periodo t.				
Valor	5585	Unidad de Medida	Nacimientos	Fecha	2018
Medio de verificación	Departamento de Generación de Estadísticas de Natalidad y Nupcialidad. Subdirección de Estadísticas Vitales. Dirección General de Estadística.		Fuente	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	
Variable C	Total de adolescentes entre 15 y 19 años en periodo t.				
Valor	95152	Unidad de Medida	Mujeres	Fecha	2018
Medio de verificación	Proyecciones de la Población a mitad de año, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050. Dirección		Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).	

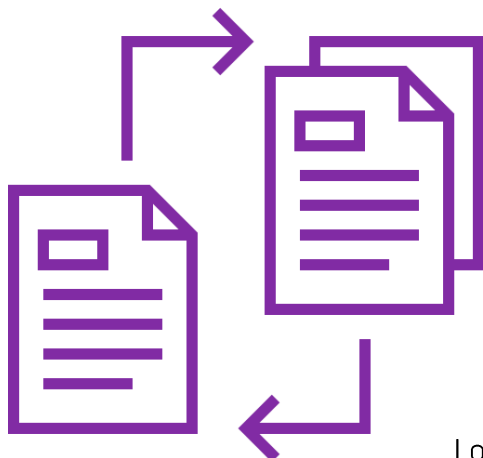
		General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva.			
Variable D		Factor de expansión.			
Valor	1000	Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación	NA		Fuente	NA	
Línea Base					
Valor	58.7	Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Promedio nacional	66.32		Lugar que ocupa el estado	26	
Tendencia del Clasificador		Descendente			
Metas					
Meta 2021	57.8		Fecha	Dic 2021	
Meta 2024	57.0		Fecha	Dic 2024	
Meta 2030	55.0		Fecha	Dic 2030	
Criterios de evaluación					
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.			
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.			
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.			

Tema estratégico	Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.				
Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes.				
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 5, meta 5.6. Objetivo 3, meta 3.7.				
Nombre del Indicador	Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.				
Definición	Mide la proporción de mujeres de 15 a 24 años de edad que se encuentran sexualmente activas y manifiestan querer evitar, limitar o espaciar un embarazo, pero no utilizan un método anticonceptivo.				
Descripción	Permite conocer la brecha entre las intenciones reproductivas de las mujeres y su comportamiento anticonceptivo.				
Tipo de algoritmo	Porcentaje	Periodicidad de cálculo	No determinada		
Fecha de Referencia	Diciembre 2018	Fecha de actualización	ND		
Ficha Técnica de Indicadores					
Formula de calculo	A=A				
Tendencia	Descendente	Dimensión	Eficacia		
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento	Secretaría de las Mujeres (Semujeres).				
Variables					
Variable A	Porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 24 años con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.				
Valor	26.35	Unidad de Medida	Porcentaje	Fecha	2018
Medio de verificación	Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.		Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).	
Variable B	NA				
Valor	NA	Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación	NA		Fuente	NA	
Variable C	NA				
Valor	NA	Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación	NA		Fuente	NA	
Línea Base					
Valor	26.35	Unidad de Medida	Porcentaje	Fecha	2018
Promedio nacional	22.33		Lugar que ocupa el estado	9	
Tendencia del Clasificador	Descendente				
Metas					
Meta 2021	25.00		Fecha	Dic 2021	
Meta 2024	23.00		Fecha	Dic 2024	
Meta 2030	20.00		Fecha	Dic 2030	
Criterios de evaluación					
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.			
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.			
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.			

Tema estratégico	Autonomía, curso y proyecto de vida.				
Objetivo	Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables.				
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 8, metas 8.3 y 8.5.				
Nombre del Indicador	Tasa de desocupación de la población de 15 a 19 años.				
Definición	Mide la proporción de adolescentes de 15 a 19 años que forman parte de la Población Económicamente Activa y se encuentran buscando un empleo u ocupación en un periodo determinado.				
Descripción	Permite conocer el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años que pertenecen a la Población Económicamente Activa desempleada, es decir, que no tiene un empleo y se encuentra buscando uno.				
Tipo de algoritmo	Porcentaje	Periodicidad de cálculo	Anual		
Fecha de Referencia	Diciembre 2018	Fecha de actualización	Diciembre 2021		
Ficha Técnica de Indicadores					
Formula de calculo	A=A				
Tendencia	Descendente	Dimensión	Eficacia		
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento	Secretaría de las Mujeres (Semujeres).				
Variables					
Variable A	Tasa de desocupación de la población de 15 a 19 años.				
Valor	3.76	Unidad de Medida	Porcentaje	Fecha	2018
Medio de verificación	Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.		Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).	
Variable B	NA				
Valor	NA	Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación	NA		Fuente	NA	
Variable C	NA				
Valor	NA	Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación	NA		Fuente	NA	
Línea Base					
Valor	3.76	Unidad de Medida	Porcentaje	Fecha	2018
Promedio nacional	6.97		Lugar que ocupa el estado	28	
Tendencia del Clasificador	Descendente				
Metas					
Meta 2021	3.70		Fecha	Dic 2021	
Meta 2024	3.60		Fecha	Dic 2024	
Meta 2030	2.50		Fecha	Dic 2030	
Criterios de evaluación					
No Satisfactorio	Menos del 90% de la meta.				
Satisfactorio	Entre 90 y 100% de la meta.				
Sobresaliente	Más del 100% de la meta.				

Tema estratégico	Autonomía, curso y proyecto de vida.					
Objetivo	Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos.					
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 5, meta 5.6. Objetivo 3, meta 3.7.					
Nombre del Indicador	Incidencia registrada de Infecciones de Transmisión Sexual en mujeres de 10 a 19 años.					
Definición	Mide la cantidad de casos nuevos registrados de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en niñas y adolescentes de 10 a 19 años por cada 100, 000 niñas y mujeres adolescentes de 10 a 19 años.					
Descripción	Debido a que no existen encuestas poblacionales que brinden información sobre la prevalencia de ITS en población de 10-19 años, no es posible el reporte de prevalencias de ITS. Por ello, el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA propone la incidencia registrada de ITS en el grupo de población señalado, como un indicador próximo para la medición de las infecciones en el grupo de 10 a 19 años. Los códigos de la CIE-10 contemplados en el numerador por ITS son: Chancro blando (A57); herpes genital (A60.0); infección gonocócica genitourinaria (A54.0-A54.2); linfogranuloma por clamidias (A55); sífilis adquirida (A51-A53); tricomoniasis urogenital (A59.0) e infección por VPH (B97.7).					
Tipo de algoritmo	Tasa		Periodicidad de cálculo	Anual		
Fecha de Referencia	Diciembre 2018		Fecha de actualización	Diciembre 2021		
Ficha Técnica de Indicadores						
Formula de calculo	A=A					
Tendencia	Descendente		Dimensión	Eficacia		
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento		Secretaría de las Mujeres (Semujeres).				
Variables						
Variable A		Tasa de incidencia registrada de Infecciones de Transmisión Sexual en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.				
Valor	31.98		Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Medio de verificación		Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.		Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).	
Variable B		NA				
Valor	NA		Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación		NA		Fuente	NA	
Variable C		NA				
Valor	NA		Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación		NA		Fuente	NA	
Línea Base						
Valor	31.98		Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Promedio nacional		46.32		Lugar que ocupa el estado	26	
Tendencia del Clasificador		Descendente				
Metas						
Meta 2021		31.00		Fecha	Dic 2021	
Meta 2024		30.00		Fecha	Dic 2024	
Meta 2030		28.00		Fecha	Dic 2030	
Criterios de evaluación						
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.				
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.				
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.				

Tema estratégico	Autonomía, curso y proyecto de vida.					
Objetivo	Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos.					
Vinculación con las Metas de los ODS	Objetivo 5, meta 5.6. Objetivo 3, meta 3.7.					
Nombre del Indicador	Incidencia registrada de Infecciones de Transmisión Sexual en hombres de 10 a 19 años.					
Definición	Mide la cantidad de casos nuevos registrados de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en niños y hombres adolescentes de 10 a 19 años por cada 100,000 niños y hombres adolescentes de 10 a 19 años.					
Descripción	Debido a que no existen encuestas poblacionales que brinden información sobre la prevalencia de ITS en población de 10-19 años, no es posible el reporte de prevalencias de ITS. Por ello, el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA propone la incidencia registrada de ITS en el grupo de población señalado, como un indicador próximo para la medición de las infecciones en el grupo de 10 a 19 años. Los códigos de la CIE-10 contemplados en el numerador por ITS son: Chancro blando (A57); herpes genital (A60.0); infección gonocócica genitourinaria (A54.0-A54.2); linfogranuloma por clamidias (A55); sífilis adquirida (A51-A53); tricomoniasis urogenital (A59.0) e infección por VPH (B97.7).					
Tipo de algoritmo	Tasa		Periodicidad de cálculo	Anual		
Fecha de Referencia	Diciembre 2018		Fecha de actualización	Diciembre 2021		
Ficha Técnica de Indicadores						
Formula de calculo	A=A					
Tendencia	Descendente		Dimensión	Eficacia		
Dependencia o Entidad responsable del seguimiento		Secretaría de las Mujeres (Semujeres).				
Variables						
Variable A		Tasa de incidencia registrada de Infecciones de Transmisión Sexual en hombres de 10 a 19 años.				
Valor	9.05		Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Medio de verificación		Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA.		Fuente	Consejo Nacional de Población (Conapo).	
Variable B		NA				
Valor	NA		Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación		NA		Fuente	NA	
Variable C		NA				
Valor	NA		Unidad de Medida	NA	Fecha	NA
Medio de verificación		NA		Fuente	NA	
Línea Base						
Valor	9.05		Unidad de Medida	Tasa	Fecha	2018
Promedio nacional		8.51		Lugar que ocupa el estado	15	
Tendencia del Clasificador		Descendente				
Metas						
Meta 2021		8.90		Fecha	Dic 2021	
Meta 2024		8.50		Fecha	Dic 2024	
Meta 2030		7.00		Fecha	Dic 2030	
Criterios de evaluación						
No Satisfactorio		Menos del 90% de la meta.				
Satisfactorio		Entre 90 y 100% de la meta.				
Sobresaliente		Más del 100% de la meta.				



PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Los Programas y Proyectos Estratégicos podrían entenderse como un conjunto integral de políticas y líneas de acción orientadas a un ámbito sectorial, territorial o demográfico, con las que se busca obtener un cambio en un periodo de mediano o largo plazo.

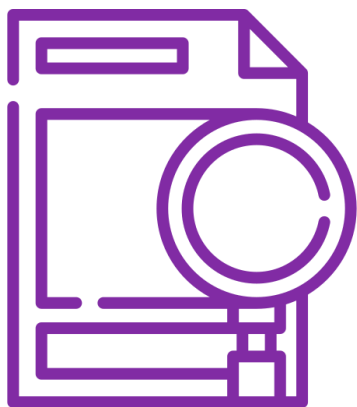
Al ser de un nivel operativo, los programas y proyectos estratégicos deben definir los criterios y condiciones para la determinación de líneas de acción que contemplen programas, proyectos y actividades institucionales, que vincule la planeación con la programación y la presupuestación.

En este apartado se describen los programas y proyectos estratégicos que se llevarán a cabo durante la Administración 2019 – 2024, mismos que se derivan de los diagnósticos correspondientes:

- **Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes;**
- **Programa Integral de Atención a la Infancia y la Familia.**

Los temas propuestos se plantean como áreas de atención viables de alcanzar en el periodo de la presente Administración y los mismos se enfocan al alcance de los objetivos de desarrollo, considerando de manera individual la descripción, la población de referencia, así como el análisis territorial para la atención de problemas específicos. En estos temas quedan incluidas las actividades estratégicas, que desde el sector público se implementan para salvaguardar el derecho al acceso de las niñas, niños y adolescentes a la salud sexual y reproductiva.

Ambos programas y actividades disponen de un objetivo único que facilita la evaluación de los resultados individuales; además de los correspondientes indicadores que permiten la medición de dichos resultados en el mediano plazo. Asimismo, para cada programa o proyecto se definen las políticas administrativo-operativas, territoriales, de financiamiento y beneficiarios, que establecen las reglas generales que se pondrán en práctica durante el periodo de vigencia y constituyen el marco de referencia de actuación; es decir son los principios fundamentales o lineamientos que orientarán las líneas de acción en las diferentes etapas.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED) tiene como propósito verificar y evaluar la ejecución de los programas públicos y el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los instrumentos de planeación y programación. Este Sistema forma parte del Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo, el cual se encuentra dirigido a mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos ejercidos, aunado a una demanda poblacional por tener sistemas transparentes y efectivos del gasto público. En este sentido se evaluará el presente Programa de Mediano Plazo mediante una serie de indicadores que se detalla a continuación, lo cual garantizará la correcta ejecución y permitirá conocer el avance de los objetivos.

Objetivo	Nombre del indicador	Dependencia responsable	Área de contacto	Periodicidad	Fecha de actualización
Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada	Porcentaje de abandono escolar en el nivel media superior	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021
	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel de educación media superior	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021
Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	Tasa Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 años de edad	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021
	Tasa Específica de Fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021

Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021
Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables	Tasa de desocupación de la población de 15 a 19 años	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021
Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Incidencia registrada de Infecciones de Transmisión Sexual en mujeres de 10 a 19 años	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021
	Incidencia registrada de Infecciones de Transmisión Sexual en hombres de 10 a 19 años	Secretaría de las Mujeres	Departamento de Sistemas de Información	Anual	2021



RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES CON LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EL PRESUPUESTO

Según lo establecido el modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), la planeación y la presupuestación deben ser congruentes, es decir, lo que se considera importante para la planeación debe verse reflejado en las prioridades del gasto público. Lo anterior es posible cuando se establece una correcta transición entre la elaboración de los programas especiales y la de los programas presupuestarios.

En este contexto, un Programa Presupuestario es la intervención pública objeto de asignación de recursos presupuestales, integrada por dos o más componentes, que tiene como propósito resolver un problema social, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, mediante la adquisición, producción y entrega de dos o más bienes y servicios públicos contemplados a corto plazo, en este caso anual, de acuerdo a lo planeado en el año fiscal a través de la Unidad Básica de Presupuestación (UBP).

Ante lo anterior, la vinculación de los Programas de Mediano Plazo con Programas Presupuestarios puede establecerse de la siguiente forma:

- **Fin.** El objetivo a nivel de Fin de un Programa Presupuestario deberá contribuir al logro de un objetivo estratégico de orden superior contenido en el Plan Estatal de Desarrollo. Las dependencias y entidades deberán alinear el nivel de fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de sus programas presupuestarios a un objetivo de desarrollo; lo anterior, con el propósito de que la ejecución de dichos programas coadyuve a la consecución del objetivo en cuestión.
- **Propósito.** Es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica el cambio de servicios otorgados por el programa. Deberá estar orientado hacia el cumplimiento del objetivo del Programa de Mediano Plazo al que se encuentre alineado.
- **Componentes.** Son los bienes o servicios que se entregan o producen durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. Los componentes se derivan de las líneas de acción de los Programas de Mediano Plazo.
- **Actividades.** Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los componentes.

Con base en el siguiente formato de vinculación, se identificaron los programas presupuestarios derivados del presente Programa de Mediano Plazo.

Programas presupuestarios con indicadores

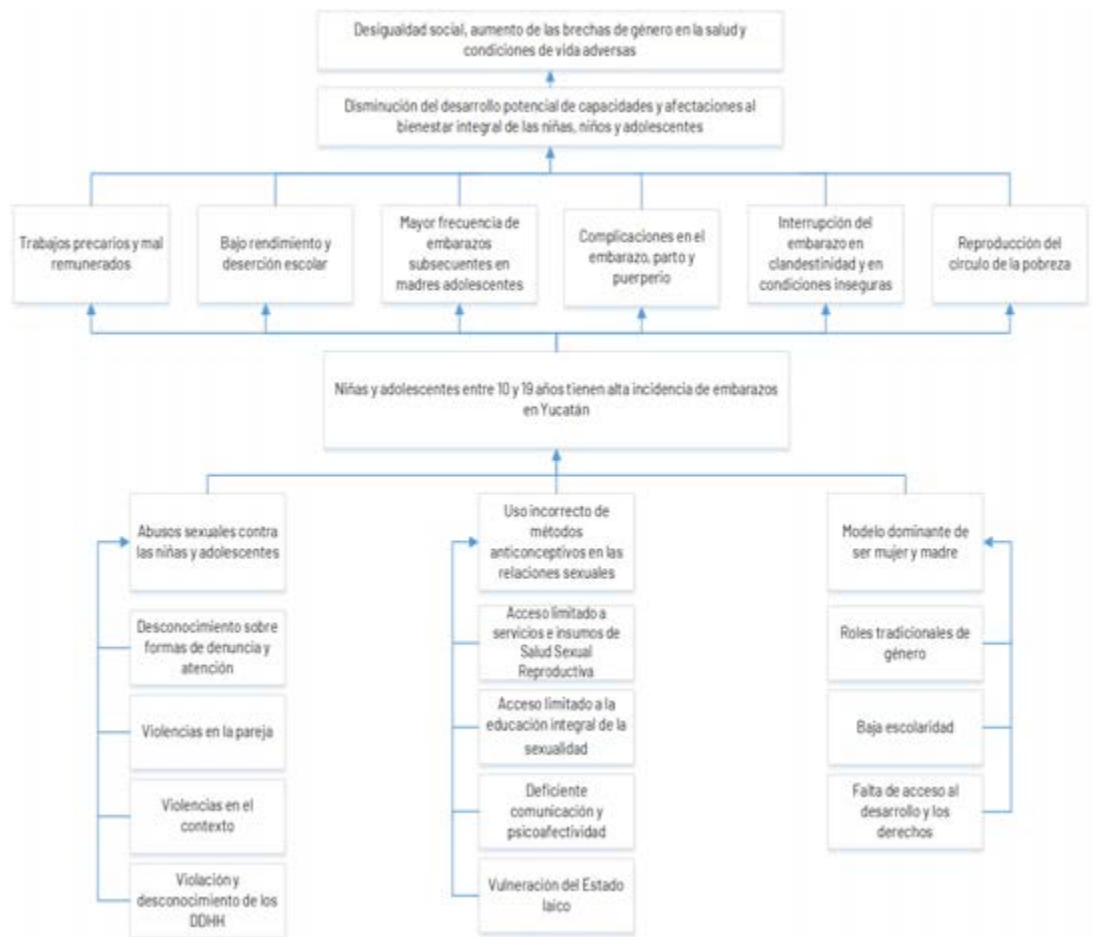
Tabla 3. Relación de programas presupuestarios derivados del PMP.

Dependencia (s) responsable (s)	Nombre Programa Presupuestario	Fin	Indicador Fin	Propósito	Indicador Propósito
Secretaría de las Mujeres	Prevención del Embarazo en Adolescentes	Se contribuye a reducir las brechas de género en salud mediante el desarrollo del potencial y la promoción del bienestar integral de niñas, niños y adolescentes	Índice de desarrollo humano en salud para las mujeres	Las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años tienen baja incidencia de embarazos	Tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años Tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años

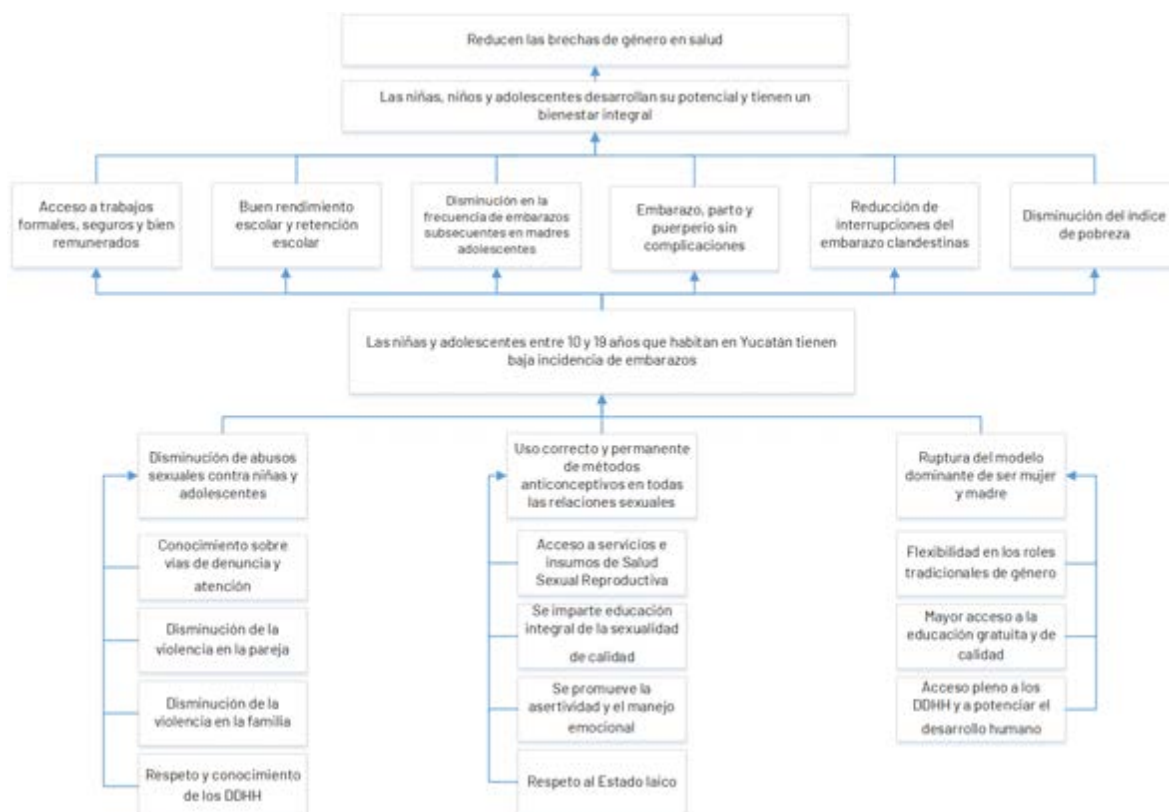


I. ANEXOS

ANEXO 1. Árbol de problemas



ANEXO 2. Árbol de objetivos



ANEXO 3. Objetivos, estrategias y líneas de acción y su alineación

Eje del PED	Objetivo del Eje del PED	Política pública del PED	Objetivo de la Política Pública del PED	Tema estratégico del PMP	Objetivo del PMP	Estrategia del PMP	Línea de acción del PMP	Programa Presupuestario asociado a Objetivo del PED	ODS asociado a objetivo del PED
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.1 Fomentar esquemas educativos integrales, inclusivos y flexibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes, que les permita concluir la educación obligatoria.	1.1.1.1 Promover mecanismos para la reincorporación escolar de niñas, niños y adolescentes con énfasis en las necesidades específicas de zonas rurales e indígenas.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión	Estrategia 1.1.1 Fomentar esquemas educativos integrales, inclusivos y flexibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes, que les permita	1.1.1.2 Proporcionar apoyos para la inclusión, permanencia y conclusión de los estudios para reducción de costos de asistir a la escuela.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4

					pública y privada.	concluir la educación obligatoria.			
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.1 Fomentar esquemas educativos integrales, inclusivos y flexibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes, que les permita concluir la educación obligatoria.	1.1.1.3 Desarrollar actividades que generen actitudes, cuidados a la salud, habilidades para la vida y de orientación vocacional en educación básica y media superior.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.1 Fomentar esquemas educativos integrales, inclusivos y flexibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes, que les permita concluir la educación obligatoria.	1.1.1.4 Facilitar la profesionalización y capacitación del personal docente en temas de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género, autonomía y habilidades para la vida.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.2 Favorecer la educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1.1.2.1 Diseñar contenidos de educación Integral de la sexualidad, con énfasis en salud sexual, salud reproductiva y de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.2 Favorecer la educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1.1.2.2 Desarrollar procesos permanentes de capacitación y formación para el personal docente en la enseñanza de contenidos de educación integral en sexualidad.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.2 Favorecer la educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1.1.2.3 Facilitar el establecimiento de vínculos escolares con el entorno comunitario y familiar para la promoción de la educación integral en sexualidad, derechos	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4

							humanos, género e interculturalidad.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.2 Favorecer la educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1.1.2.4 Estimular procesos de aprendizaje sobre sexualidad, género y violencias contra las niñas y adolescentes mujeres a través de actividades artísticas en espacios comunitarios	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.3 Impulsar la igualdad de oportunidades educativas para las niñas y adolescentes en situación de embarazo, así como para las niñas y adolescentes madres en el nivel básico y medio superior.	1.1.3.1 Promover la entrega de becas educativas a las niñas y adolescentes madres o en situación de embarazo que habiten en comunidades indígenas y que se encuentren en los municipios identificados como prioritarios.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.3 Impulsar la igualdad de oportunidades educativas para las niñas y adolescentes en situación de embarazo, así como para las niñas y adolescentes madres en el nivel básico y medio superior.	1.1.3.2 Facilitar el establecimiento de modalidades de estudio que permitan la formación en educación básica de niñas madres y en situación de embarazo.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	Estrategia 1.1.3 Impulsar la igualdad de oportunidades educativas para las niñas y adolescentes en situación de embarazo, así como para las niñas y adolescentes madres en el nivel básico y medio superior.	1.1.3.3 Promover mecanismos educativos especiales de alfabetización que permitan regularizar a niñas y adolescentes madres en planteles de educación secundaria y de educación media superior.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en educación	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades	Objetivo 1.1 Ampliar las oportunidades educativas de las niñas, niños y	Estrategia 1.1.3 Impulsar la igualdad de oportunidades educativas para las niñas y	1.1.3.4 Desarrollar mecanismos interinstitucionales para garantizar la permanencia escolar de las	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 4

				s para niñas, niños y adolescentes	adolescentes en los niveles obligatorios de la gestión pública y privada.	adolescentes en situación de embarazo, así como para las niñas y adolescentes madres en el nivel básico y medio superior.	madres adolescentes y estudiantes en situación de embarazo, en un ambiente de igualdad, inclusión y no discriminación.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.1.Implementar acciones para la detección y prevención oportuna de la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	1.2.1.1 Generar acciones para la detección, canalización y denuncia de los casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes con especial atención en las zonas rurales, indígenas, urbano marginadas, de contexto migrante y en municipios prioritizados.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	Estrategia 1.2.1.Implementar acciones para la detección y prevención oportuna de la violencia sexual contra las	1.2.1.2 Ejecutar acciones de difusión en municipios y comisarías para que la población detecte y denuncie las violencias en	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

					adolescentes .	niñas, niños y adolescentes	contra de niñas y adolescentes, con mayor énfasis en el tipo sexual y sus nuevas modalidades, como la digital.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.1.Implementar acciones para la detección y prevención oportuna de la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	1.2.1.3 Poner en marcha la difusión de herramientas para detectar la pornovenganza, el ciberacoso sexual, abuso sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes y a la sociedad en general.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.1.Implementar acciones para la detección y prevención oportuna de la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	1.2.1.4 Desarrollar capacitaciones y procesos formativos dirigidos a hombres jóvenes, adolescentes y niños sobre masculinidades alternas en la corresponsabilidad del ejercicio de la sexualidad	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.1.Implementar acciones para la detección y prevención oportuna de la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	1.2.1.5 Implementar acciones de difusión en maya y español para difundir la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, Criterios para la Prevención y Atención.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.2 Favorecer los servicios especializados en la atención a la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes	1.2.2.1 Reforzar el trabajo coordinado con las autoridades municipales para brindar servicios de detección de violencia sexual y atención integral y especializada en espacios comunitarios para niñas, niños y adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.2 Favorecer los servicios especializados en la atención a la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes	1.2.2.2 Formular una ruta institucional para denuncias y atenciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

				niños y adolescentes	las niñas, niños y adolescentes	niñas, niños y adolescentes	niños y adolescentes, por jurisdicción de los municipios de Yucatán.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	Estrategia 1.2.2 Favorecer los servicios especializados en la atención a la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes	1.2.2.3 Promover la capacitación continua de los equipos de atención primaria a la salud para la detección del abuso sexual.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	Estrategia 1.2.2 Favorecer los servicios especializados en la atención a la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes	1.2.2.4 Proporcionar los servicios de profilaxis, de anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por normatividad vigente, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima de violencia sexual.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.2 Favorecer los servicios especializados en la atención a la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes	1.2.2.5 Capacitar a personal clave estatal y municipal en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, Criterios para la Prevención y Atención.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.3 Impulsar acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia sexual.	1.2.3.1 Establecer medidas de protección especializadas de niñas, niños y adolescentes en los procesos de intervención jurídica, principalmente durante la etapa de identificación y persecución penal de las personas acusadas de violación.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	Estrategia 1.2.3 Impulsar acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia sexual.	1.2.3.2 Proporcionar procesos de contención emocional para las personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia sexual.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes	Estrategia 1.2.3 Impulsar acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia sexual.	1.2.3.3 Promover la capacitación en normativas como la NOM-046-SSA2-2005 al personal del servicio público responsable de programas vinculados con la prevención y asistencia a las víctimas de violencia sexual.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y	Estrategia 1.2.3 Impulsar acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido	1.2.3.4 Facilitar vínculos con las Casas Hogar para la realización de acciones coordinadas que permitan la detección oportuna de situaciones de	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

					adolescentes .	violencia sexual.	violencia sexual en infantes y adolescentes.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.2 Disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes .	Estrategia 1.2.3 Impulsar acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia sexual.	1.2.3.5 Supervisar la atención integral y el respeto estricto de los derechos humanos de infantes y adolescentes que se encuentran en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE)	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.1 Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.	1.3.1.1 Ampliar la cobertura de los servicios amigables de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes, asegurando una atención igualitaria, aceptable, accesible y efectiva.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.1 Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.	1.3.1.2 Fortalecer la capacidad institucional de los servicios que se brindan a los Hospitales Comunitarios para responder a las necesidades relacionadas con la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en niñas y adolescentes madres.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.1 Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.	1.3.1.3 Promover vínculos interinstitucionales con escuelas, centros de salud, farmacias y programas de gobierno que se implementen a nivel municipal para promover los servicios de salud sexual reproductiva a la ciudadanía y priorizando en las y los adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.1 Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.	1.3.1.4 Poner en marcha un programa de salud sexual y reproductiva que se implemente a través de los Hospitales Comunitarios y que otorgue servicios clínicos al grupo etario de 10 a 19 años, con sustento en el marco normativo y regulatorio para otorgar servicios de salud sexual y reproductiva.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.1 Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.	1.3.1.5 Proporcionar a la población adolescente información sobre los servicios del sector salud, de las organizaciones de la sociedad civil y de las farmacias u otros espacios vinculados.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.1 Promover servicios de salud sexual-reproductiva amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles para las y los adolescentes.	1.3.1.6 Promover la formación de adolescentes y jóvenes como promotoras y promotores de la salud sexual y reproductiva en sus comunidades.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	1.3.2.1 Promover mecanismos de difusión en los municipios del estado sobre salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, género e interculturalidad y sobre la gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	1.3.2.2 Diseñar esquemas novedosos para la oferta y el suministro de métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, por medio de diferentes esquemas de provisión de fijos o itinerantes, dentro y fuera de las instituciones de salud, para las y los adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	1.3.2.3 Facilitar la implementación de dispensadores públicos de condones femeninos y masculinos en instancias educativas, centros de salud y en lugares estratégicos y al alcance de las y los adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	1.3.2.4 Reforzar la calidad de la consejería brindada a adolescentes en el primer y segundo nivel de atención.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	1.3.2.5 Capacitar al personal médico y profesionales en los servicios de salud en temas de salud sexual y reproductiva, perspectiva de las juventudes y género, desde una visión laica e intercultural.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción	1.3.2.6 Brindar información sobre métodos anticonceptivos a niñas y adolescentes madres y en situación de embarazo, en los diferentes momentos de	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 3

						prolongada (ARAP).	contacto (consulta prenatal, parto, puerperio y control de la niña y niño sano).		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Reducir las brechas de género en salud	Tema Estratégico I Bienestar integral en igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes	Objetivo 1.3 Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes	Estrategia 1.3.2 Impulsar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP).	1.3.2.7 Establecer mecanismos para asegurar que las y los adolescentes accedan a la gama completa de métodos anticonceptivos sin trámites complejos, en pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y	Estrategia 2.1.1 Impulsar las acciones culturales y deportivas en las niñas, niños y adolescentes para favorecer su curso y proyecto de vida.	2.1.1.1 Crear redes de fomento al liderazgo y la participación ciudadana, compuestas por jóvenes en comunidades de los municipios del estado.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 10

					responsables .				
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables .	Estrategia 2.1.1 Impulsar las acciones culturales y deportivas en las niñas, niños y adolescentes para favorecer su curso y proyecto de vida.	2.1.1.2 Facilitar talleres y espacios comunitarios sobre arte y cultura dirigidos a las niñas, niños y adolescentes en municipios y comisarías.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 10
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y	Estrategia 2.1.1 Impulsar las acciones culturales y deportivas en las niñas, niños y adolescentes para favorecer su curso y proyecto de vida.	2.1.1.3 Promover la práctica deportiva y activación física, libre de estereotipos e incluyente, dirigida niñas, niños y adolescentes en escuelas, parques y espacios comunitarios en	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 10

					responsables .		los municipios del estado.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables .	Estrategia 2.1.1 Impulsar las acciones culturales y deportivas en las niñas, niños y adolescentes para favorecer su curso y proyecto de vida.	2.1.1.4 Proporcionar becas de apoyo al deporte a niñas y adolescentes madres para promover la permanencia en la formación deportiva.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 10
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y	Estrategia 2.1.2 Impulsar la ocupación de adolescentes en edad legal para trabajar acorde a sus capacidades para el diseño de su proyecto de vida	2.1.2.1 Poner en marcha talleres de capacitación para el empleo y autoempleo de las y los adolescentes en edad legal de trabajar.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 8

					responsables .				
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y responsables .	Estrategia 2.1.2 Impulsar la ocupación de adolescentes en edad legal para trabajar acorde a sus capacidades para el diseño de su proyecto de vida	2.1.2.2 Promover la celebración de convenios de coordinación con empresas formales para la contratación de personal adolescente en edad legal de trabajar	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 8
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.1 Incrementar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que favorezcan la toma de decisiones autónomas y	Estrategia 2.1.2 Impulsar la ocupación de adolescentes en edad legal para trabajar acorde a sus capacidades para el diseño de su proyecto de vida	2.1.2.3 Diseñar programas duales de estudio y trabajo dirigidos a adolescentes en edad legal de trabajar.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 8

					responsables				
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.	2.2.1.1 Motivar la participación de las y los adolescentes en los procesos de planeación e implementación de las acciones de gobierno para la prevención del embarazo en adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y	Estrategia 2.2.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el	2.2.1.2 Consolidar el Reglamento para el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

					reproductivos	diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.			
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.	2.2.1.3 Registrar datos desgregados por sexo y edad u otras variables relevantes de los programas de gobierno en torno a la prevención y atención del embarazo en adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.	2.2.1.4 Gestionar convenios de coordinación con escuelas y sociedad civil organizada para realizar acciones conjuntas en la prevención del embarazo en adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos,	2.2.1.5 Desarrollar capacitaciones sobre derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos, al personal integrante del Grupo Estatal para la Prevención del	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

						perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.	Embarazo en Adolescentes (GEPEA), para el diseño de políticas públicas con perspectiva de juventudes, género e interculturalidad.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de las juventudes, perspectiva de género e interculturalidad.	2.2.1.6 Generar un sistema de información para el seguimiento de acciones de cumplimiento a los componentes de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), así como las recomendaciones e informes solicitadas por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA).	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.2 Impulsar la creación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	2.2.2.1 Facilitar conocimientos e información sobre derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, dirigidos a personal estratégico de los Ayuntamientos Municipales.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.2 Impulsar la creación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	2.2.2.2 Asesorar a los gobiernos municipales en la instalación y operación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.2 Impulsar la creación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	2.2.2.3 Motivar la participación de las y los adolescentes en los procesos de planeación de las acciones de gobierno para la prevención del embarazo en adolescentes a nivel municipal,	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

							con especial atención en aquellos municipios que son prioritarios para su intervención.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.3 Promover la armonización legislativa en materia de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.	2.2.3.1 Difundir la normatividad nacional e internacional que sustenta la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir educación integral de la sexualidad, sin discriminación alguna.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.3 Promover la armonización legislativa en materia de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.	2.2.3.2 Ajustar la normatividad estatal y municipales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, en alineación con la	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5

							normatividad nacional e internacional.		
Igualdad de género, Oportunidades y No-Discriminación	Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las Mujeres	Igualdad de Género	Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres	Tema Estratégico II Autonomía, curso y proyecto de vida	Objetivo 2.2 Incrementar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos	Estrategia 2.2.3 Promover la armonización legislativa en materia de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.	2.2.3.3 Analizar el marco jurídico estatal y municipal para identificar los instrumentos que requieren ser armonizados en materia de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.	PP 430 Prevención del Embarazo en Adolescentes	ODS 5



REFERENCIAS

Amezcu, Melissa y Peralta, Montserrat. 03/03/2020. "El aborto legal en México tras una violación es un camino tortuoso". Ciudad de México: El Universal. En línea: <https://interactivo.eluniversal.com.mx/2020/aborto-legal/>

CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). 2017. "La regulación sobre los derechos sexuales y reproductivos en la legislación mexicana y para conocer el grado de cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para prevención y atención, en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca". En línea: <https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Estudio-sobre-NOM-046-2005.pdf>

Código de la Administración Pública de Yucatán. Última reforma publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: 22 de abril de 2019. Recuperado a partir de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03006.pdf>

CONAPO (Consejo Nacional de Población). 2017. Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del registro de nacimiento, 1990-2016" en La situación demográfica de México 2017 (Ciudad de México, en prensa).

CONAPO (Consejo Nacional de Población) 2018. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. Población a inicio de año. En línea: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050/resource/fb9ec49a-8ecc-4b88-b33a-5f1f560c514f?inner_span=True

Constitución Política del Estado de Yucatán. Última Reforma publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: 13 de marzo de 2020. Recuperado a partir de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01001.pdf>

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 06 de marzo de 2020. Recuperado a partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf

Decreto 285/2015 por el que se emite la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y se modifica el Código de Familia para el Estado de Yucatán; la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán; la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán; la Ley de Salud del Estado de Yucatán; la Ley de Educación del Estado de Yucatán; la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán; el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; el Código Civil del Estado de Yucatán; el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán; la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán y la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán. Publicado en el Diario Oficial del Estado: 12 de junio de 2015.

UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). 2013. *Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes*. En línea: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ES-SWOP2013.pdf>

GIPEA (Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes). 2020. Segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA 2018.

García, Brígida y Edith Pacheco (Coord.). 2014. *Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México*. México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos.

Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE). 2018. "La pieza faltante. Justicia Reproductiva". Ciudad de México: <https://justiciareproductiva.gire.org.mx/assets/pdf/JusticiaReproductiva.pdf>

Gobierno de México. (2015). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Ciudad de México.

INE (Instituto Nacional Electoral). 2015. Consulta Infantil y Juvenil 2015, Resultados por Entidad, municipio y sexo.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2015. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados, Estados Unidos Mexicanos, Población. En línea: <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados>.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2015b. Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. En línea: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&c=11817>.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2016. Encuesta Intercensal 2015. Panorama sociodemográfico de Yucatán 2015. En línea: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082437.pdf

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2016b. *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares*. En línea: <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/>

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2017. Estadísticas a propósito del día de la madre. (Ciudad de México: INEGI, 2017) http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2018. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. En línea: <https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/>

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2019. Estadísticas de Natalidad 2018. Nacimientos registrados por municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento.

- IPAS. 2018. *Violencia sexual y embarazo infantil en México. Un problema de salud pública y derechos humanos*. En línea: <https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20Me%CC%81xico.%20un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81blica%20y%20derechos%20humanos.pdf>
- Ley de Planeación. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 16 de febrero de 2018. Recuperado a partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
- Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. Última Reforma publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: 31 de julio de 2019. Recuperado a partir de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2013/DIGESTUM02294.pdf>
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 14 de junio de 2018. Recuperado a partir de http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf
- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. Última Reforma publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: 31 de Julio De 2019. Recuperado a partir de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2016/DIGESTUM02334.pdf>
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 2017. Base de datos "Familia". Tasas de Fertilidad. En línea: <http://www.oecd.org/social/family/database.htm>
- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2020. "El embarazo en la adolescencia". En línea: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- Páez Domínguez, Olinca Dessirée. 2017. "Determinantes de la distribución de la población en edad de trabajar: un estudio de cambios y continuidades en tres cohortes de mexicanas". En: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Realidad, Datos y Espacio, Revista Internacional de Estadística y Geografía*, Vol. 8, Núm, 1, enero-abril 2017.
- Pantelides, Edith Alejandra. 2004. "Aspectos sociales del embarazo y la fecundidad adolescente en América Latina". En: *Notas de población, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)*. En línea: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12759/np78007033_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Plan Estatal de Desarrollo del Estado De Yucatán. Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: 30 de marzo de 2019. Recuperado a partir de http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf
- Rodríguez Vignoli, Jorge. 2012. "La reproducción en la adolescencia en América Latina: viejas y nuevas vulnerabilidades". En: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Realidad, Datos y Espacio, Revista Internacional de Estadística y Geografía*, Vol. 3, Núm, 2, mayo-agosto 2012.
- Stern, Claudio. 1997. "El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica". En: *Salud pública de México*, vol. 39, no.2, marzo-abril de 1997.
- Schiavon, Raffaella. 2016. "Panorama general de la carga de enfermedades en adolescentes en México". Conferencia presentada en el Congreso de Salud Pública, noviembre de 2016, Mérida Yucatán).
- Szasz, Ivonne y Lerner, Susana. 2012. "Salud reproductiva y desigualdades en la población". En: Manuel Ordorica y Jean Francois Prud'homme (Coord.), *Los grandes problemas de México*, El Colegio de México.

Urbina-Fuentes M, Jasso-Gutiérrez L, Schiavon-Ermani R, Lozano R, Finkelman J. 2017. "La transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud y la equidad en salud". Gaceta Médica de México (2017, pp. 153): 697-730. https://www.anmm.org.mx/GMM/2017/n6/GMM_153_2017_6_697-730.pdf

PROGRAMA ESPECIAL

**EDICIÓN ELABORADA EN LA DIRECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.**

PODER EJECUTIVO



CONSEJERIA JURIDICA